

Bunga Rampai **PERAN STRATEGIS TENAGA KESEHATAN**

DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Aisyah Maulina Zjubaidi • Kursih Sulastriningsih • Ayu Mustika Handayani
Resta B. Wirata • AASP Chandradewi • Syaiful

Editor : Hakim Tobroni



BUNGA RAMPAI

PERAN STRATEGIS TENAGA KESEHATAN DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Penulis:

Aisyah Maulina Zjubaidi, SKM., M.Si.
Dr. Bdn. Kursih Sulastriningsih, SSiT., M.Kes.
Ayu Mustika Handayani, S.ST., M.Kes.
Resta B. Wirata, S.Kep., Ns., MSN.
AASP Chandradewi SKM., M.Kes.
Syaiful, S.Kep., Ns, MPd., MKes.

Editor:

Ns. Hakim Tobroni HR, S.Kep., M.Tr.Kep.



BUNGA RAMPAI PERAN STRATEGIS TENAGA KESEHATAN DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Penulis:

Aisyah Maulina Zjubaidi, SKM., M.Si.
Dr. Bdn. Kursih Sulastriningsih SSiT., M.Kes.
Ayu Mustika Handayani, S.ST., M.Kes.
Resta B. Wirata, S.Kep., Ns., MSN.
AASP Chandradewi SKM., M.Kes.
Syaiful, S.Kep., Ns, MPd., MKes.

Editor: Ns. Hakim Tobroni HR, S.Kep., M.Tr.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7556-79-0

Cetakan Pertama : Maret, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku “Bunga Rampai: Peran Strategis Tenaga Kesehatan dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat” dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menghadirkan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran tenaga kesehatan dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat praktik pelayanan yang tidak hanya berfokus pada kuratif, tetapi juga promotif, preventif, rehabilitatif, dan pemberdayaan masyarakat.

Derajat kesehatan masyarakat merupakan indikator penting kesejahteraan bangsa. Namun, pencapaiannya tidak dapat dilepaskan dari berbagai determinan yang saling terkait, seperti lingkungan, perilaku, akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta faktor genetik. Dalam konteks Indonesia, keberagaman geografis, sosial budaya, dan ketimpangan akses layanan menghadirkan tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan derajat kesehatan. Karena itu, tenaga kesehatan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam edukasi, skrining, pencegahan penyakit, penguatan literasi kesehatan, advokasi kebijakan, hingga kolaborasi lintas sektor untuk membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh.

Bunga rampai ini disusun untuk mengangkat berbagai perspektif dan praktik nyata yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pemahaman konsep dasar derajat kesehatan, determinan kesehatan, promosi dan pencegahan, penguatan pelayanan primer, hingga inovasi pendekatan berbasis komunitas di era transformasi digital. Setiap pembahasan diupayakan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, praktisi kesehatan, pendidik, serta pengelola program dalam merancang intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat membutuhkan sinergi berbagai pihak. Oleh karena itu, buku ini juga menekankan pentingnya kolaborasi interprofesional dan lintas sektor—melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, serta keluarga sebagai unit terkecil yang memegang peran penting dalam pembentukan perilaku sehat. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi pada pemberdayaan, diharapkan upaya peningkatan kesehatan dapat lebih efektif, efisien, dan berdampak jangka panjang.

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan buku ini, baik melalui kontribusi pemikiran, masukan, maupun dukungan moral. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga buku “Bunga Rampai: Peran Strategis Tenaga Kesehatan dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat” dapat memberikan manfaat luas, memperkaya wawasan, serta menjadi salah satu sumber referensi untuk memperkuat peran tenaga kesehatan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.

Maret, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA..... 1

Aisyah Maulina Zjubaidi, SKM, M.Si.	1
A. Pendahuluan / Prolog.....	1
B. Faktor Lingkungan.....	2
C. Faktor Perilaku Masyarakat.....	5
D. Faktor Pelayanan Kesehatan	8
E. Faktor Genetik.....	10
F. Simpulan.....	11
G. Referensi.....	12
H. Glosarium.....	16

CHAPTER 2 PERAN STRATEGIS TENAGA KESEHATAN DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT 17

Dr. Bdn. Kursih Sulastriningsih, SSiT., M.Kes.....	17
A. Pendahuluan / Prolog.....	17
B. Konsep Dasar Tenaga Kesehatan dan Derajat Kesehatan.....	18
C. Peran Strategis Tenaga Kesehatan Masyarakat	19
D. Peran Nakes dalam Pembangunan Kesehatan.....	20
E. Tantangan dan Strategi Penguatan Peran Nakes	21
F. Simpulan.....	24
G. Referensi.....	25
H. Glosarium.....	26

CHAPTER 3 KONTRIBUSI KEBIDANAN TERHADAP PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK.....27

Ayu Mustika Handayani, S.ST., M.Kes.	27
A. Pendahuluan / Prolog.....	27
B. Peran Penting Bidan dalam Menjaga Kesehatan Ibu dan Anak.....	28
C. Kontribusi Utama Bidan Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak	29
E. Tantangan dan Permasalahan Utama Bidan di Masyarakat.....	36
F. Simpulan.....	39
G. Referensi.....	40

H. Glosarium.....	43
CHAPTER 4 PERAN KEPERAWATAN DALAM PENINGKATAN KESEHATAN INDIVIDU DAN KELUARGA	45
Resta Betaliani Wirata, S.Kep., Ns., MSN.	45
A. Pendahuluan / Prolog.....	45
B. Konsep Dasar Peran Keperawatan.....	46
C. Peran Keperawatan dalam Peningkatan Kesehatan Individu.....	48
D. Peran Keperawatan dalam Konteks Keluarga	51
E. Simpulan.....	54
F. Referensi.....	55
G. Glosarium	56
CHAPTER 5 PERAN GIZI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT.....	57
AASP Chandradewi, SKM., M.Kes.....	57
A. Pendahuluan / Prolog.....	57
B. Konsep Dasar Gizi dalam Kerangka Kesehatan Masyarakat.....	59
C. Hubungan antara Status Gizi, Stunting, dan CIAF.....	63
D. Hubungan antara Status Gizi, Stunting, dan Indikator Komposit seperti Composite Anthropometric Failure (CIAF).....	64
E. Urgensi Intervensi Gizi sebagai Strategi Pembangunan Kesehatan Jangka Panjang	67
F. Implikasi Kebijakan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Mendukung Perbaikan Status Gizi Masyarakat.....	68
G. Simpulan.....	70
H. Referensi.....	71
I. Glosarium.....	72
CHAPTER 6 PENDEKATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN	73
Syaiful, S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.....	73
A. Pendahuluan / Prolog.....	73
B. Pendekatan Promotif dan Preventif Dalam Tinjauan Teoritis	73
C. Simpulan.....	77
D. Referensi.....	77
E. Glosarium	78
PROFIL PENULIS	79

CHAPTER 1

DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINGYA

Aisyah Maulina Zjubaidi, SKM, M.Si.

A. Pendahuluan / Prolog

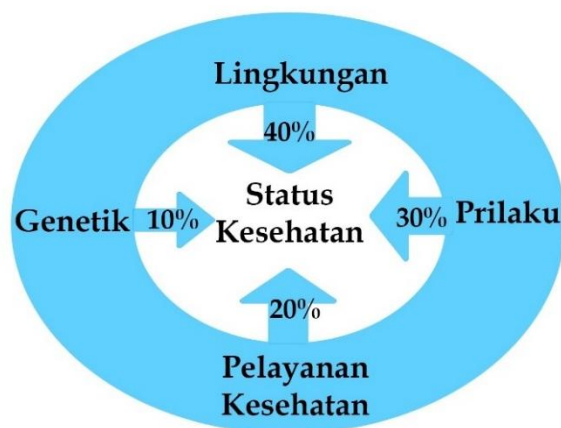
Sebelum membahas tentang derajat atau tingkat kesehatan masyarakat, marilah kita renungkan kondisi kesehatan masyarakat Indonesia saat ini. Kondisi cukup positif terjadi ketika prevalensi stunting nasional berhasil diturunkan dari 21,5% pada tahun 2023 menjadi 19,8% pada penghujung 2024 (Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 2025) dan diprediksi terus melandai di awal 2026. Ini adalah sebuah kemenangan kecil bagi derajat kesehatan, khususnya gizi, anak-anak kita.

Namun, terdapat kenyataan yang tidak menyenangkan yaitu hampir 28% penduduk masih mengeluhkan gangguan kesehatan setiap bulannya (BPS, 2024). Sementara penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes dan hipertensi terus mengintai kelompok usia produktif dan penyakit menular yang sudah diupayakan penanggulangannya seperti TBC juga belum sepenuhnya dapat ditangani (Kemenkes, 2024). Angka-angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas kerja Kementerian Kesehatan; mereka adalah cerita tentang anak di pelosok Nusa Tenggara Timur yang masih berjuang melawan *underweight*, atau pekerja urban di Jakarta yang terjebak dalam polusi udara, kemacetan, gaya hidup sedentari dan pola makan tidak sehat.

Fenomena lain kondisi kesehatan adalah pelayanan kesehatan untuk masyarakat sudah semakin baik dengan 90% masyarakat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (BPS, 2025), namun apakah akses dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit sudah merata? Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dirasakan meningkat dengan melimpahnya informasi kesehatan di media internet. Informasi kesehatan ini tidak lagi diragukan kebenarannya karena disampaikan oleh dokter dan tenaga kesehatan (Jasmine, 2025; Tahira et al, 2025), namun apakah pengetahuan ini sudah mampu mengubah gaya hidup masyarakat menjadi makin sehat?

Berbagai pertanyaan dan tinjauan kritis mengemuka saat membicarakan tentang derajat kesehatan masyarakat yang merupakan indikator utama kesejahteraan sebuah bangsa. Derajat kesehatan masyarakat bukan sekadar ketiadaan penyakit, melainkan sebuah kondisi keseimbangan yang dinamis.

Marilah kita tinjau dari pandangan yang dikemukakan oleh Hendrik L. Blum seorang ahli kesehatan masyarakat pada tahun 1974 yang masih relevan untuk kondisi saat ini. Blum (dalam Marpaung, 2022) menyatakan bahwa status atau derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi banyak hal yang dirangkum dalam empat faktor. Pertama adalah faktor lingkungan yang merupakan faktor terbesar. Kemudian dilanjutkan dengan faktor perilaku masyarakat dan faktor pelayanan kesehatan. Faktor terkecil yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah faktor genetik. Bab ini akan menguraikan keempat faktor tersebut.



Gambar 1.1 Status/Derajat Kesehatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (dimodifikasi dari Blum, 1974)

Memahami keempat faktor ini secara holistik sangat penting bagi tenaga kesehatan agar intervensi yang dilakukan tidak hanya menyentuh gejala klinis, tetapi juga akar permasalahannya. Keempat faktor tersebut dapat kita analogikan sebagai empat pilar yang menyangga status atau derajat kesehatan masyarakat.

B. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan memegang kontribusi terbesar (40%) terhadap derajat kesehatan sehingga dapat kita katakan sebagai pilar utama. Lingkungan bukan hanya tentang hijaunya hutan atau birunya laut; ia mencakup udara yang kita hirup, air yang kita gunakan sehari-hari, sistem pembuangan limbah di sekitar kita, hingga tata kota yang menunjang mobilitas sehat.

Pikirkan sejenak: mengapa anak-anak di daerah dengan akses sanitasi buruk lebih rentan diare dan menderita stunting? Mengapa warga di kota-kota besar lebih sering batuk dan alergi pernapasan? Jawabannya ada pada polusi udara dari kendaraan dan industri, pengelolaan sampah yang belum optimal dan ketersediaan fasilitas air bersih yang belum merata. Data menunjukkan bahwa kualitas udara di

beberapa kota besar masih jauh dari standar sehat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022), sementara hanya sekitar 75% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap sanitasi layak per 2023, menyisakan jutaan jiwa rentan terhadap penyakit berbasis lingkungan (Kemenkes, 2023).

Lingkungan yang sehat merupakan prasyarat mutlak. Tanpa fondasi ini, upaya promotif dan preventif yang dilakukan tenaga kesehatan akan terasa seperti mengisi air ke dalam ember bocor—terus-menerus dilakukan, tetapi hasilnya tidak optimal. Ketersediaan air bersih yang terjamin, sistem pembuangan limbah yang efektif, serta ruang terbuka hijau yang memadai, adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan langsung terlihat pada penurunan angka kesakitan masyarakat.

Lingkungan mencakup dimensi fisik (sanitasi, air bersih), biologis (vektor penyakit), hingga lingkungan sosial-budaya. Seringkali, tenaga kesehatan merasa tak berdaya ketika menghadapi pasien yang berulang kali datang dengan keluhan yang sama. Namun, jika kita merujuk pada pemikiran Blum, kegagalan tersebut mungkin bukan pada obatnya, melainkan pada lingkungan tempat pasien itu kembali. Lingkungan fisik, biologis, dan sosial adalah determinan yang paling mempengaruhi derajat kesehatan. Tanpa keberanian tenaga kesehatan untuk keluar dari ruang periksa dan mengintervensi faktor lingkungan—mulai dari mengadvokasi air bersih hingga mengubah norma sosial—maka upaya kesehatan hanya akan menjadi pemadam kebakaran bagi api yang terus disulut oleh lingkungan yang tidak sehat.

1. Lingkungan Fisik dan Kimiawi

Lingkungan fisik dan kimia mencakup kualitas udara, air, tanah, perumahan, hingga kebisingan. Lingkungan fisik sangat mempengaruhi derajat kesehatan antara lain pada pencegahan stunting (S. Noviyanti, 2020), kejadian tuberculosis (S. Rahmawati, 2021), bahkan terjadinya stress kerja (Putra, A. D., & Saraswati, A., 2022). Pada program penanganan stunting, intervensi kondisi lingkungan berupa akses sanitasi dan air bersih sangat penting. Data kesehatan menunjukkan bahwa infeksi berulang akibat sanitasi buruk menyedot nutrisi anak, sehingga pemberian gizi tambahan (intervensi medis) menjadi tidak efektif. Penanganan tuberculosis juga penting memperhatikan kondisi tempat tinggal pasien antara lain ventilasi, kelembaban dan pencahayaan. Lingkungan fisik tempat kerja yang tidak optimal antara lain berupa pencahayaan, kebisingan dan suhu udara perlu diintervensi agar stress kerja tidak meningkat menjadi masalah kesehatan jiwa.

2. Lingkungan Biologis

Mencakup keberadaan agen penyakit (virus, bakteri), vektor (seperti nyamuk *Aedes aegypti*), hingga ketersediaan pangan. Pengaruh lingkungan biologis pada kesehatan dapat dilihat pada upaya pengendalian penyakit menular seperti

demam berdarah dengue atau malaria. Upaya pengendalian vektor kedua penyakit tersebut sangat bergantung pada pengelolaan lingkungan biologis (Hamid, 2023). Tanpa pengendalian sarang nyamuk, upaya pengobatan di puskesmas hanya akan menyelesaikan dampak, bukan akar masalah. Salah satu upaya pengendalian sarang nyamuk adalah jumentik (juru pemantau jentik) yang berkaitan erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian upaya mengatasi faktor lingkungan biologi erat kaitannya dengan intervensi pada faktor perilaku manusia dan faktor lingkungan sosial (Rahayu, D., & Cahyati, W., 2023).

3. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Faktor ini sering terlupakan namun krusial, mencakup tingkat pendidikan, pendapatan, kepadatan penduduk, hingga kebijakan pemerintah. Tingkat pendidikan masyarakat memengaruhi pemahaman dan perilaku sehatnya. Status ekonomi memengaruhi kemampuan masyarakat mengakses makanan bergizi atau hunian yang sehat. Kebijakan pemerintah pun sangat krusial mempengaruhi derajat kesehatan antara lain pada ketersediaan fasilitas kesehatan, kejadian polusi udara, keamanan dan lainnya.

Manusia/masyarakat merupakan faktor utama dari kondisi lingkungan sosial budaya. Masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan kondisi ekonomi baik akan lebih memahami upaya kesehatan dan menerima perubahan perilaku sehat.

Di sisi lain, masih ada lingkungan sosial budaya yang dapat menjadi kendala bagi tercapainya derajat kesehatan yang tinggi, yaitu adanya stigma. Jika kita merujuk pada pandangan Blum tentang lingkungan, stigma dapat dianalogikan sebagai bentuk pencemaran dalam lingkungan sosial. Sama seperti polusi udara yang merusak paru-paru, stigma terhadap penyakit tertentu (seperti HIV/AIDS, kusta, gangguan jiwa, atau bahkan stunting) menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi individu. Seseorang yang terstigma sering kali enggan mencari bantuan karena takut akan diskriminasi atau label negatif dari masyarakat (Hatzenbuehler, 2013) dan bahkan dari kalangan tenaga kesehatan (Ariasih & Zjubaidi, 2025). Dampak akhir dari stigma adalah meningkatnya angka kesakitan (morbiditas), kematian (mortalitas), dan menurunkan kualitas hidup. Intervensi pada stigma perlu dilakukan di berbagai level sosial-ekologis, mulai dari level individu hingga kebijakan publik karena siapa pun bisa mengalami atau melakukan stigmatisasi dalam konteks yang berbeda (Stangl et al, 2019).

C. Faktor Perilaku Masyarakat

Setelah faktor lingkungan, pilar penyangga derajat kesehatan adalah perilaku masyarakat. Ini adalah faktor yang seringkali paling sulit diubah, namun memiliki dampak yang tak kalah signifikan. Bayangkan, Anda memiliki rumah dengan fondasi kuat, sistem sanitasi sempurna, lingkungan minim polusi, tetapi Anda selalu makan makanan cepat saji, malas bergerak, dan merokok di dalam rumah. Apa yang terjadi? Perlahan tapi pasti, kesehatan Anda akan terkikis.

Perilaku mencakup antara lain kebiasaan makan, tingkat aktivitas fisik, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, praktik kebersihan diri (mencuci tangan, mandi), hingga penggunaan layanan kesehatan. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, misalnya, menyoroti tantangan perilaku. Angka obesitas pada orang dewasa terus meningkat, sementara konsumsi buah dan sayur harian masyarakat masih di bawah rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Lebih dari itu, kebiasaan merokok masih menjadi momok serius, dengan prevalensi perokok aktif yang stagnan di angka tinggi, terutama pada kelompok remaja.

Secara umum, perilaku merupakan hasil dari tiga determinan internal yaitu kognitif, afektif dan psikomotor (Bloom dalam Karim, 2018).

1. Kognitif

Perilaku dipengaruhi pengetahuan dan kesadaran seseorang tentang apa yang sehat dan apa yang berbahaya. Namun, pengetahuan tentang kesehatan yang baik tidak sama dengan perilaku sehat yang dilakukan. Kita dapat melihat bahwa banyak orang tahu merokok itu berbahaya bagi kesehatan, tetapi tetap merokok.

2. Afektif

Perilaku sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi. Jika masyarakat merasa bahwa bertubuh gemuk adalah tanda kemakmuran, maka program pencegahan obesitas akan sulit diterima secara mental.

3. Psikomotor

Faktor psikomotor berupa tindakan nyata yang dilakukan berulang kali hingga menjadi kebiasaan. Mulai dari pola makan, aktivitas fisik, pola tidur, hingga kepatuhan minum obat.

Para ahli perilaku menyadari bahwa terjadinya perilaku, termasuk perilaku kesehatan, terbentuk melalui suatu proses internal dalam diri seseorang. Para ahli menjelaskan dalam beberapa teori berikut ini:

1. *Health Belief Model*

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang akan berubah jika dia merasa terancam dan melihat keuntungan dari perubahan tersebut (Rosenstock dalam Mahindaratne, 2021; Alyafei A, Easton-Carr R, 2024). Perilaku

kesehatan dipengaruhi oleh pengetahuan, namun seseorang tidak cukup hanya punya pengetahuan tentang bahaya suatu penyakit, namun pasien perlu merasa rentan secara pribadi. Contoh: pasien perlu tahu tentang penyakit diabetes yang dideritanya dan merasakan bahwa diabetes berbahaya (*Perceived Susceptibility*) dan bahwa komplikasi diabetes sangat serius (*Perceived Severity*) jika tidak ditangani dengan baik. Teori ini juga memasukkan pentingnya keyakinan diri (*self efficacy*) masyarakat dalam melakukan perilaku sehat. Contohnya, saat pandemi COVID, edukasi tentang upaya pencegahannya dapat lebih efektif dengan memasukkan panduan mengenali kemampuan diri dan dukungan lingkungan untuk melakukannya (Mahindaratne, 2021).

2. Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini menyatakan bahwa perilaku adalah hasil dari niat (*intention*) sebagai faktor motivasi, sikap, tekanan sosial (*Subjective Norms*) dan kontrol perilaku yang dirasakan (*Perceived Behavioral Control*) (Ajzen dalam Tapera et al, 2020). Faktor-faktor tersebut dapat mendorong atau menghambat perilaku sehat seseorang. Teori ini menyebutkan pentingnya melihat perilaku dalam konteks lingkungan sosial dan persepsi tentang kemampuan diri. Misalnya, jika lingkungan sosial menganggap merokok adalah simbol perilaku keren dan berani, maka niat seseorang untuk berhenti akan rendah (Su et al, 2015; Tapera et al, 2020). Apalagi jika seseorang merasa tidak yakin pada kemampuannya untuk berhenti merokok. Suatu studi lainnya dengan TPB menyebutkan bahwa konsumsi *fast-food* pada mahasiswa dipengaruhi oleh teman dan meningkatnya popularitas jenis makanan tersebut, sementara itu pengetahuan mereka tentang dampak negatif *fast food* masih kurang (Sajjad, 2023).

Mengingat pengaruh norma kelompok pada perilaku kesehatan seseorang, maka penting melakukan intervensi perilaku kesehatan tidak hanya pada individu, namun juga pada komunitasnya.

3. Transtheoretical Model (TTM)

Teori dari Prochaska & DiClemente (1983) ini menjelaskan bahwa perubahan perilaku adalah sebuah proses bertahap. TTM memiliki enam tahapan perubahan: 1) pra-kontemplasi: orang tersebut tidak menyadari memiliki masalah, tidak memiliki informasi tentang hal itu, dan tidak berniat mengubah perilakunya dalam 6 bulan ke depan; 2) Kontemplasi: ada niat untuk mengubah perilaku dalam 6 bulan ke depan; 3) Persiapan: rencana terstruktur telah dibuat untuk mengubah perilaku dalam waktu kurang dari satu bulan; 4) Tindakan: perilaku baru telah diimplementasikan setidaknya selama satu bulan; 5) Pemeliharaan: perubahan perilaku telah dipertahankan selama enam bulan; dan

6) Konsolidasi: perilaku telah dipertahankan selama satu hingga lima tahun (Prochaska & DiClemente, 1983 dalam Padilla López et al, 2025)

Petugas kesehatan yang akan melakukan intervensi untuk mengubah perilaku seseorang atau masyarakat perlu mengetahui di tahap perubahan mana seseorang berada. Misalnya, seseorang yang belum sadar bahaya kurang gizi (tahap pra-kontemplasi) perlu mendapat edukasi terlebih dahulu. Sedangkan seseorang yang telah mengetahui bahaya merokok namun masih merokok (tahap kontemplasi) perlu mendapatkan dorongan dan evaluasi pada *self-efficacy*.

Studi-studi berikut menyebutkan bahwa desain intervensi yang personal berdasarkan kerangka TTM berhasil menjamin keberlanjutan aktivitas fisik (olahraga) pada pasien hipertensi (Padilla López et al, 2025) dan perilaku merokok di kalangan siswa sekolah menengah atas (Lee dan Song, 2015 dalam Park dan Song, 2024).

Memahami perilaku masyarakat sebagai penentu 30% derajat kesehatan menuntut tenaga kesehatan untuk memahami psikologi perubahan manusia. Pandangan Blum menjadi jauh lebih operasional ketika tenaga kesehatan meminjam kacamata tiga teori tersebut. Tenaga kesehatan perlu menyadari bahwa perilaku sehat tidak lahir hanya dari kepintaran seseorang, melainkan dari rasa aman, tekanan lingkungan sosial, dan keyakinan diri. Tenaga kesehatan yang strategis adalah mereka yang mampu mendiagnosis 'tahapan perubahan' masyarakatnya, memastikan bahwa pesan kesehatan yang disampaikan tidak hanya tepat secara medis, tetapi juga tepat secara psikologis dan sosiologis.

Perilaku Kesehatan di Era Digital

Di era transformasi teknologi saat ini, perilaku kesehatan masyarakat mengalami pergeseran paradigma. Media sosial dan platform digital telah menjadi "lingkungan informasi" baru yang secara radikal memengaruhi bagaimana individu membuat keputusan kesehatan. Perilaku kesehatan tidak hanya sebagai tindakan fisik, tetapi juga sebagai tindakan digital tentang cara orang mencari informasi medis menyaring hoaks, hingga membagikan pengalaman kesehatan mereka secara daring.

Beberapa fenomena yang penting dicermati tenaga kesehatan antara lain:

1. Fenomena Cyberchondria dan Self-Diagnosis

Akses tanpa batas terhadap informasi kesehatan sering kali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan otonomi pasien; di sisi lain, ia melahirkan perilaku *self-diagnosis* yang tidak akurat. Masyarakat cenderung melakukan diagnosis mandiri berdasarkan pencarian internet yang memicu

kecemasan berlebih atau dikenal sebagai *cyberchondria* (Starcevic dan Berle, 2013; Starcevic, Berle, dan Arnáez, 2020).

2. Pengaruh Echo Chambers dan Hoaks Kesehatan

Algoritma media sosial sering kali menjebak masyarakat dalam *echo chambers* (ruang gema), di mana mereka hanya terpapar pada informasi yang mendukung keyakinan mereka, misalnya perilaku anti-vaksin atau pengobatan alternatif yang tidak berbasis bukti. Saat ini memang sudah banyak tenaga kesehatan yang menjadi "influencer kesehatan" yang aktif di ruang digital, namun hoaks informasi kesehatan masih terus ada dan dipercaya oleh banyak orang.

3. Quantified Self dan Pemantauan Mandiri

Penggunaan *wearable devices* (perangkat yang dapat dipakai) dan aplikasi kesehatan telah mengubah perilaku dari reaktif menjadi proaktif. Masyarakat kini lebih sadar untuk memantau data detak jantung, pola tidur, hingga asupan kalori harian mereka. Perangkat tersebut digunakan untuk memantau antara lain kesadaran kesehatan, kesehatan fisik dan kesehatan mental (Pardamean et al, 2020).

D. Faktor Pelayanan Kesehatan

Jika lingkungan dan perilaku adalah upaya pencegahan di hulu, maka pelayanan kesehatan adalah benteng pertahanan sekaligus kompas di hilir. Derajat kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih alat pacu jantung di rumah sakit kota, tetapi seberapa cepat seorang ibu di desa terpencil mendapatkan imunisasi untuk bayinya. Selain ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, pemerataan akses dan kualitas layanan juga menjadi isu yang perlu diperhatikan.

1. Ketersediaan

a. Ketersediaan Fasilitas Fisik (Puskesmas dan RS)

Saat ini terdapat sekitar 10.280 unit Puskesmas dan 3.270 unit rumah sakit (RS) di seluruh Indonesia (Kemenkes, 2025). Hampir setiap kecamatan memiliki setidaknya satu Puskesmas sebagai fasilitas layanan kesehatan primer. Sedangkan mayoritas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum (RSU) tipe C dan D yang menjadi tulang punggung layanan rujukan di daerah. Kementerian Kesehatan saat ini sedang melakukan transformasi layanan primer dengan melakukan integrasi layanan primer (ILP).

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pelayanan kesehatan tidak dapat berjalan tanpa adanya tenaga kesehatan. Saat ini Indonesia terus mengejar target rasio ideal 1:1.000 (satu dokter untuk seribu penduduk). Saat ini, meskipun secara nasional angka tersebut mulai

mendekati target, distribusinya masih sangat timpang. Di kota besar seperti Yogyakarta, rasionya mencapai 1,70 namun di provinsi baru atau daerah terpencil, angka ini bisa turun hingga di bawah 0,5 (Kemenkes, 2025).

Kabar baiknya, sekitar 96% Puskesmas sudah memiliki dokter (Kemenkes, 2025). Namun, tantangannya ada pada "9 Jenis Tenaga Kesehatan Standar" (termasuk apoteker, tenaga kesehatan masyarakat dan sanitasi) yang seharusnya lengkap di setiap puskesmas. Saat ini, baru sekitar 56-60% Puskesmas yang benar-benar lengkap timnya sesuai standar nasional. Akibatnya, layanan kesehatan seringkali terjebak pada pengobatan medis semata, sementara upaya pencegahan di tingkat masyarakat sering kali terabaikan karena keterbatasan personel.

c. Jaminan Kesehatan

Ketersediaan layanan juga bergantung pada kemampuan masyarakat untuk membayar. Pemerintah Indonesia mengupayakan terpenuhinya jaminan kesehatan semesta bagi seluruh rakyat Indonesia. Hampir 97% penduduk terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang populer disebut BPJS-Kesehatan (BPJS, 2025; BPS, 2024). Kondisi ini dapat diartikan bahwa secara finansial, layanan kesehatan "tersedia" bagi hampir seluruh rakyat. Keberhasilan ini perlu dilihat lebih kritis dengan pembahasan berikut berkaitan dengan akses layanan kesehatan.

2. Pemerataan Akses Layanan Kesehatan

Walaupun hampir seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN, namun data menunjukkan hanya 30-35% peserta JKN yang memanfaatkannya setiap tahunnya (BPJS, 2025; BPS, 2024). Pemanfaatan JKN paling tinggi tercatat berada di wilayah dengan fasilitas kesehatan lengkap (Jawa dan Bali). Di wilayah Indonesia timur, meski kepesertaan JKN mencapai lebih 90%, angka kunjungannya jauh lebih rendah. Angka ini menyimpan paradoks: di satu sisi kita bersyukur bagi mereka yang tetap sehat sehingga tidak perlu berobat dengan JKN. Di sisi lain kita harus bertanya, berapa banyak warga di pelosok yang menjadi peserta namun tak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan karena kendala biaya transportasi atau jarak tempuh yang jauh. Bahkan ada peserta JKN yang tidak tahu prosedur rujukan sehingga merasa sulit menggunakannya. Akses layanan kesehatan yang tidak merata ini tentu mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

3. Kualitas Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya tersedia fasilitasnya dan kemudahan akses, namun penting memperhatikan kualitas layanannya. Kualitas yang kita bahas berdasar pada

prinsip yang ditetapkan oleh *Institute of Medicine (IOM)*, yang menekankan bahwa pelayanan kesehatan disebut berkualitas jika menyembuhkan secara medis (efektif), dan diberikan secara aman, tepat waktu, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan pasien (Institute of Medicine, 2001). Aspek kualitas juga memperhitungkan interaksi tenaga kesehatan dan pasien yang mempengaruhi kepuasan dan kesembuhan (Donabedian, 1988).

E. Faktor Genetik

Dalam teori H.L. Blum faktor ini disebut memiliki kontribusi paling kecil (sekitar 10%), namun di era medis modern tahun 2026, pemahaman tentang faktor ini menjadi sangat strategis bagi tenaga kesehatan. Faktor genetik merupakan satu-satunya hal yang tidak bisa kita pilih atau ubah. Kita lahir dengan membawa "pesan biologis" dari orang tua kita, mulai dari warna mata hingga risiko terhadap penyakit tertentu seperti diabetes tipe-2, hipertensi, thalassemia, hingga kanker. Namun, memiliki bakat genetik terhadap suatu penyakit bukanlah sebuah "vonis mati".

Genetika tidak bekerja sendirian; ia berinteraksi dengan lingkungan dan perilaku. Seorang individu mungkin memiliki "bakat" genetik diabetes, namun melalui intervensi gaya hidup yang personal (*personalized prevention*) maka bakat tersebut tidak terwujud menjadi penyakit. Dengan demikian, memahami faktor hereditas bukan lagi soal nasib biologis, melainkan tentang mengambil kendali atas masa depan kesehatan melalui deteksi dini yang berbasis data genomik. Suatu kajian menyatakan bahwa peluang deteksi dini dan pengobatan berbasis data genomik di Indonesia sangat menjanjikan, bahkan World Health Organization juga mendorong tiap negara menuju penggunaan data genomik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (WHO, 2022). Namun beberapa hal perlu menjadi perhatian sebelum melaksanakan program tersebut, antara lain regulasi tentang data pasien, terutama keamanan data, infrastruktur dan sumber daya manusia (Hisan dan Amri, 2020).

Kementerian Kesehatan pun mengikuti tren global yang bertujuan mendeteksi potensi penyakit di masa depan sekaligus menghadirkan pengobatan yang presisi (*precision medicine*) bagi masyarakat melalui inisiatif *Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi)*. Teknologi ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk tidak hanya mengobati gejala, tetapi memahami variasi genetik khas populasi Indonesia dan membantu masyarakat memetakan risiko kesehatan mereka.

Dengan demikian walaupun kita tidak dapat mengubah faktor genetik, namun itu bukanlah akhir cerita. Pengetahuan tentang peta genetika seseorang dan upaya mengatasi berbagai risiko kesehatan dengan pengobatan presisi, menjadi masa depan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

F. Simpulan

Derajat kesehatan masyarakat merupakan indikator kesejahteraan bangsa yang bukan sekadar ketiadaan penyakit, melainkan kondisi keseimbangan dinamis. Berdasarkan teori Hendrik L. Blum, terdapat empat faktor utama yang saling berkaitan dan memengaruhi status kesehatan tersebut:

1. Faktor Lingkungan (kontribusi 40%). Sebagai pilar utama, lingkungan mencakup dimensi fisik, kimiawi, biologis, hingga sosial-budaya. Kualitas sanitasi, air bersih, serta tata kota sangat memengaruhi risiko penyakit seperti stunting, diare, dan gangguan pernapasan. Selain aspek fisik, lingkungan sosial juga berperan penting, di mana stigma terhadap penyakit tertentu dapat menghambat individu untuk mencari bantuan medis karena takut akan diskriminasi.
2. Faktor Perilaku Masyarakat (kontribusi 30%). Perilaku merupakan hasil dari proses kognitif (pengetahuan), afektif (nilai/tradisi), dan psikomotor (tindakan nyata). Meskipun sulit diubah, perilaku seperti pola makan, aktivitas fisik, dan merokok memiliki dampak signifikan pada kesehatan. Di era digital, perilaku kesehatan juga dipengaruhi oleh informasi internet yang dapat memicu fenomena *self-diagnosis* atau *cyberchondria*.
3. Faktor Pelayanan Kesehatan (kontribusi 20%). Faktor ini mencakup ketersediaan fasilitas fisik (Puskesmas dan RS), sebaran sumber daya manusia kesehatan, serta sistem jaminan kesehatan (JKN). Meskipun kepesertaan JKN hampir mencapai 97%, tantangan utama terletak pada pemerataan akses dan kualitas layanan yang harus memenuhi standar efektif, aman, tepat waktu, serta menghormati nilai kemanusiaan pasien.
4. Faktor Genetik (kontribusi 10%). Walaupun kontribusinya paling kecil, pemahaman faktor genetik kini menjadi sangat strategis di era medis modern melalui data genomik. Faktor ini memang tidak dapat diubah, namun interaksi antara genetik dengan lingkungan dan perilaku memungkinkan adanya pencegahan penyakit yang bersifat personal (*personalized prevention*) melalui inisiatif seperti *Biomedical and Genome Science Initiative* (BGSi).

Memahami keempat faktor ini secara holistik sangat penting bagi tenaga kesehatan agar intervensi tidak hanya menyentuh gejala klinis, tetapi juga akar permasalahannya. Tenaga kesehatan yang strategis harus mampu mendiagnosis tahapan perubahan masyarakat serta bertindak sebagai penghubung antara teknologi medis mutakhir dengan kondisi sosiologis masyarakat di lapangan.

Rekomendasi dan Penutup

Derajat kesehatan masyarakat merupakan sebuah kondisi keseimbangan dinamis yang tidak dapat dilepaskan dari peran empat pilar penyangga yang saling

berkelindan. Sebagaimana telah diuraikan, faktor lingkungan memegang kontribusi terbesar yang menuntut keberanian tenaga kesehatan untuk melampaui batas ruang periksa demi melakukan intervensi fisik maupun sosial, termasuk mendekonstruksi stigma yang menjadi penghambat akses layanan. Pilar perilaku sebagai penentu signifikan lainnya menuntut tenaga kesehatan untuk memahami psikologi perubahan manusia agar pesan kesehatan yang disampaikan tidak hanya tepat secara medis, tetapi juga tepat secara psikologis dan sosiologis di era digital saat ini.

Meskipun pelayanan kesehatan dan faktor genetik memiliki porsi kontribusi yang lebih kecil, keduanya tetap menjadi benteng pertahanan dan kompas masa depan yang sangat strategis. Transformasi pelayanan kesehatan melalui pemerataan akses dan kualitas, serta pemanfaatan data genomik untuk pengobatan presisi, menjadi kunci dalam menjawab tantangan kesehatan modern.

Oleh karena itu, peran tenaga kesehatan ke depan bukan lagi sekadar sebagai penyembuh klinis, melainkan mampu menyatukan keempat pilar tersebut. Rekomendasi strategis bagi tenaga kesehatan adalah:

- Sebagai advokat dan penggerak: tenaga kesehatan harus aktif mengintervensi faktor lingkungan dengan mengadvokasi kebijakan kesehatan publik dan memberdayakan modal sosial masyarakat untuk mengatasi akar masalah.
- Sebagai motivator dan kurator digital: tenaga kesehatan perlu mendiagnosis tahapan perubahan perilaku masyarakat serta membimbing mereka di tengah banjir informasi digital agar terhindar dari perilaku *self-diagnosis* yang menyesatkan.
- Sebagai penjamin kualitas dan navigator: tenaga kesehatan wajib memastikan setiap layanan yang diberikan bersifat inklusif, aman, dan berorientasi pada kemanusiaan, sembari membantu pasien menavigasi risiko genetik mereka melalui pencegahan yang personal.

Dengan pemahaman yang holistik dan peran yang transformatif, tenaga kesehatan diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia menuju kondisi yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

G. Referensi

Alyafei, A., & Easton-Carr, R. (2025). The health belief model of behavior change. Dalam *StatPearls*. StatPearls Publishing.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK606120/>

- Ariasih, A., & Maulina Zjubaidi, A. (2025). Stigma di kalangan tenaga kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa. *Jurnal Semesta Sehat (J-Mestahat)*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.58185/j-mestahat.v5i1.149>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator kesejahteraan rakyat 2024*. Penulis.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik jaminan sosial Indonesia 2023*. Penulis.
- BPJS Kesehatan. (2025). *Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan 2024*. Penulis.
- Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed? *JAMA*, 260(12), 1743–1748. <https://doi.org/10.1001/jama.260.12.1743>
- Hamid, A., Lestari, A., & Maliga, I. (2023). Analisis perbandingan faktor lingkungan terkait dengan prevalensi kejadian demam berdarah dengue (DBD) pada daerah sporadis dan daerah endemis. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 22(1), 13–20. <https://doi.org/10.14710/jkli.22.1.13-20>
- Hatzenbuehler, M. L., Phelan, J. C., & Link, B. G. (2013). Stigma as a fundamental cause of population health inequalities. *American Journal of Public Health*, 103(5), 813–821. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2012.301069>
- Hisan, U. K., & Amri, M. M. (2023). Recommendation of precision medicine application in Indonesia from multiple perspective: A review. *International Journal of Public Health Science (IJPHS)*, 12(1), 225–238. <http://doi.org/10.11591/ijphs.v12i1.22010>
- Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America. (2001). *Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century*. National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/10027>
- Jasmine, I. L. P., & Rahmawati, F. N. (2025). Influencer digital sebagai agen komunikasi kesehatan studi peran dr. Tirta di era media sosial. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2331>
- Karim, D. S. P. (2018). Determinan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) tatanan rumah tangga. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 1–10.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Laporan survei kesehatan indonesia (SKI) tahun 2023*. Penulis.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Profil kesehatan indonesia 2022: Fokus penyakit berbasis lingkungan*. Penulis.

- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Cetak biru transformasi teknologi kesehatan 2024-2029: Implementasi biomedical & genome science initiative (BGSI)*. Penulis.
- Kementerian Kesehatan RI. (2025). *Laporan survei status gizi indonesia (SSGI) tahun 2024*. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2025). *Profil kesehatan indonesia 2024*. Penulis.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Status lingkungan hidup indonesia 2022*. Penulis.
- Mahindaratne, P. P. (2021). Assessing COVID-19 preventive behaviours using the health belief model: A Sri Lankan study. *Journal of Taibah University Medical Sciences*, 16(6), 914–919. <https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2021.07.006>
- Marpaung, D. D. R., dkk. (2022). *Dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat*. Yayasan Kita Menulis.
- Novianti, S., & Padmawati, R. S. (2020). Hubungan faktor lingkungan dan perilaku dengan kejadian stunting pada balita: Scoping review. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 16(1). <https://doi.org/10.37058/jkki.v16i1.1786>
- Padilla López, J., Ortega Covarrubias, K. L., Quiñones Villalobos, C., Prado Aguilar, C. A., Márquez Romero, J. M., & Alanis Ocadiz, A. (2025). Modelo transteórico y su asociación con la actividad física en pacientes con hipertensión arterial. *Atencion Primaria*, 57(3), 103092. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2024.103092>
- Pardamean, B., Soeparno, H., Budiarto, A., Mahesworo, B., & Baurley, J. (2020). Quantified self-using consumer wearable device: Predicting physical and mental health. *Healthcare Informatics Research*, 26(2), 83–92. <https://doi.org/10.4258/hir.2020.26.2.83>
- Park, M. H., & Song, H. Y. (2024). Transtheoretical model to predict the stages of changes in smoking cessation behavior among adolescents. *Frontiers in Public Health*, 12, 1399478. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1399478>
- Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51(3), 390–395. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.51.3.390>
- Putra, A. D., & Saraswati, A. (2022). Pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap stres kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. *Indonesian Journal*

of Business and Management, 4(2), 240–249.
<https://doi.org/10.35965/jbm.v4i2.1506>

- Rahayu, D., & Cahyati, W. (2023). Karakteristik masyarakat dalam partisipasi program Gerakan Satu Rumah Satu Jumanantik. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 7(1), 67–77. <https://doi.org/10.15294/higeia.v7i1.63187>
- Rahmawati, S., Ekasari, F., & Yuliani, V. (2021). Hubungan lingkungan fisik rumah dengan kejadian tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Pekalongan Kabupaten Lampung Timur tahun 2020. *Indonesian Journal of Health and Medical (IJOHM)*, 1(2), 254–265.
- Sajjad, M., Bhatti, A., Hill, B., & Al-Omari, B. (2023). Using the theory of planned behavior to predict factors influencing fast-food consumption among college students. *BMC Public Health*, 23(1), 987. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15923-1>
- Stangl, A. L., Earnshaw, V. A., Logie, C. H., van Brakel, W., Simbayi, L. C., Barré, I., & Dovidio, J. F. (2019). The health stigma and discrimination framework: A global, crosscutting framework to inform research, intervention development, and policy on health-related stigmas. *BMC Medicine*, 17(1), Artikel 31. <https://doi.org/10.1186/s12916-019-1271-3>
- Starcevic, V., & Berle, D. (2013). Cyberchondria: Towards a better understanding of excessive health-related Internet use. *Expert Review of Neurotherapeutics*, 13(2), 205–213. <https://doi.org/10.1586/ern.12.162>
- Starcevic, V., Berle, D., & Arnáez, S. (2020). Recent insights into cyberchondria. *Current Psychiatry Reports*, 22(11), 56. <https://doi.org/10.1007/s11920-020-01179-8>
- Su, X., Li, L., Griffiths, S. M., Gao, Y., Lau, J. T., & Mo, P. K. (2015). Smoking behaviors and intentions among adolescents in rural China: The application of the Theory of Planned Behavior and the role of social influence. *Addictive Behaviors*, 48, 44–51. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.04.005>
- Tahira, K., Nurhayati, K., Putri, V. K. A., & Wahjuwibowo, I. S. (2025). Peran influencer TikTok dalam membentuk persepsi positif pendidikan seksualitas pada Generasi Z melalui akun @dokteramiraobgyn. *Konvergensi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 6(2), 243–263. <https://doi.org/10.51353/6r2jz417>
- Tapera, R., Mbongwe, B., Mhaka-Mutepfa, M., Lord, A., Phaladze, N. A., & Zetola, N. M. (2020). The theory of planned behavior as a behavior change model for

tobacco control strategies among adolescents in Botswana. *PLoS One*, 15(6), e0233462. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233462>

World Health Organization. (2022). *Accelerating access to genomics for global health: Promotion, implementation, collaboration, and ethical, legal, and social issues*. Penulis.

H. Glosarium

Algoritma media sosial: Sistem otomatis yang mengatur konten yang muncul pada pengguna; dapat memengaruhi persepsi dan keputusan kesehatan.

BGSi (Biomedical and Genome Science Initiative): Inisiatif penguatan sains biomedis dan genomik untuk pemetaan risiko penyakit dan pengembangan pengobatan presisi.

Cyberchondria: Kecemasan berlebihan akibat mencari informasi kesehatan di internet yang mendorong kekhawatiran dan self-diagnosis yang tidak akurat.

Derajat kesehatan masyarakat: Tingkat kesehatan populasi yang mencerminkan kesejahteraan fisik, mental, sosial; bukan sekadar ketiadaan penyakit.

Efikasi diri (self-efficacy): Keyakinan seseorang bahwa ia mampu melakukan perilaku sehat atau perubahan perilaku.

Fast food: Makanan cepat saji yang cenderung tinggi kalori, lemak, gula, dan garam; berkaitan dengan obesitas dan PTM.

Gizi kurang/underweight: Kondisi berat badan di bawah standar; sering berkaitan dengan asupan gizi, infeksi berulang, dan faktor lingkungan.

Health Belief Model (HBM): Teori perilaku yang menjelaskan perubahan perilaku dipengaruhi persepsi kerentanan, keparahan, manfaat, hambatan, dan efikasi di

Jumantik (juru pemantau jentik): Petugas/relawan pemantau jentik nyamuk untuk pengendalian vektor DBD, berbasis pemberdayaan masyarakat.

CHAPTER 2

PERAN STRATEGIS TENAGA KESEHATAN DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Dr. Bdn. Kursih Sulastriningsih, SSiT., M.Kes.

A. Pendahuluan / Prolog

Kesehatan merupakan aspek esensial dalam kehidupan manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan bukan sekadar bebas dari penyakit atau kelemahan, melainkan sebagai kondisi sejahtera secara menyeluruh mencakup fisik, mental, dan sosial (WHO, 1948). Pemahaman ini sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, yang mengakui kesehatan sebagai hak dasar setiap warga dan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang produktif dan berkualitas (Kemenkes RI, 2019). Dengan tercapainya derajat kesehatan yang baik, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup secara signifikan (Marmot, 2005). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan memperkuat dan memperluas dasar hukum bagi berbagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Peraturan ini juga menekankan pentingnya pembangunan kesehatan masyarakat yang ditopang oleh sumber daya kesehatan dan pengelolaan yang mengedepankan prinsip kesejahteraan, keadilan, tanpa diskriminasi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Seluruh prinsip ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperkuat layanan kesehatan yang berkualitas, serta menjamin kehidupan yang sehat dan produktif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, hingga proses pemulihan. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang memadai (Kemenkes RI, 2020). Fasyankes meliputi puskesmas, rumah sakit umum maupun khusus, serta poliklinik yang menjadi tempat pelaksanaan berbagai program pelayanan kesehatan (Permenkes No. 34 Tahun 2022).

Dalam konteks sistem kesehatan nasional, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau menjadi pilar utama dalam mewujudkan akses layanan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, masih menjadi tantangan serius yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, penguatan pelayanan di

tingkat primer melalui puskesmas menjadi langkah strategis dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat, memperluas cakupan pelayanan, serta mengurangi beban pada fasilitas kesehatan rujukan di tingkat yang lebih tinggi. Pelayanan kesehatan yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya. Konsep ini tercermin dalam pendekatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang menempatkan individu dan komunitas sebagai subjek, bukan sekadar objek layanan. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan primer, memainkan peran strategis dalam menggerakkan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif seperti penyuluhan, posyandu, program imunisasi, serta deteksi dini penyakit. Upaya ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan.

B. Konsep Dasar Tenaga Kesehatan dan Derajat Kesehatan

Tenaga kesehatan (Nakes) adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang memiliki identitas sebagai sumber daya strategis. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Terkait pentingnya tenaga kesehatan, unsur yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dijelaskan bahwa: "Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan". Tenaga kesehatan memiliki peran krusial dalam intervensi faktor perilaku dan pelayanan kesehatan.

Derajat kesehatan masyarakat, menurut Hendrik L. Blum, dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu:

1. Lingkungan

lingkungan fisik, kesehatan dipengaruhi oleh kualitas kebersihan lingkungan tempat manusia berada. Hal ini karena penyebab banyak penyakit dapat dikaitkan

dengan sanitasi lingkungan yang buruk. Karena air merupakan kebutuhan dasar manusia dan manusia selalu berinteraksi dengannya dalam kehidupan sehari-hari, maka ketersediaan air bersih di suatu masyarakat mempengaruhi derajat kesehatannya. Lingkungan sosial, di sisi lain, terkait dengan situasi ekonomi suatu masyarakat. Semakin miskin individu dan masyarakat, semakin sulit untuk mengakses kesehatan. Misalnya, manusia membutuhkan diet seimbang untuk bertahan hidup. Ketika individu dan masyarakat berada di garis kemiskinan, menjadi sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan pola makan yang seimbang. Hal yang sama berlaku untuk tingkat pendidikan individu/masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan individu/masyarakat, semakin banyak pula pengetahuan tentang pola hidup sehat.

2. Perilaku

Kesehatan dan lingkungan yang tidak sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat sangat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri, dan selanjutnya pada kebiasaan, kepercayaan, pendidikan, dan lain-lain, sehingga gaya hidup individu atau masyarakat sangat menentukan kesehatan masyarakat. Contoh: Pada masyarakat yang mengalami peralihan dari tradisional ke modern, terjadi perubahan gaya hidup pada masyarakat tersebut yang mempengaruhi tingkat kesehatan.

3. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat penting bagi pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan perawatan, serta bagi kelompok dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

4. Genetic

Faktor genetik juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan. Ini karena beberapa penyakit diwariskan secara genetik atau oleh faktor yang sudah ada pada manusia sejak lahir. Contohnya termasuk berbagai kelainan genetik seperti diabetes, asma bronkial, epilepsi, kecacatan intelektual, hipertensi, dan buta warna. Karena faktor genetik ini bawaan, sulit untuk diintervensi dan biaya intervensi sangat tinggi.

C. Peran Strategis Tenaga Kesehatan Masyarakat

Tenaga kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat, memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui pendekatan promotif dan preventif. Beberapa peran tersebut antara lain:

1. Pengubah Perilaku (Agent of Change): Mengubah perilaku masyarakat menjadi kondusif terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui promosi kesehatan.
2. Pemberdayaan Masyarakat (Empowerment): Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong diri sendiri (mandiri) untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
3. Edukator dan Konselor: Memberikan edukasi, penyuluhan, dan konseling secara tepat sasaran untuk meningkatkan kesadaran kesehatan.
4. Promotor Kesehatan: Menerapkan program dan mengadvokasi hak-hak masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya kesehatan.

Peran strategis tenaga kesehatan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat:

1. Promosi Kesehatan dan Edukasi: Tenaga kesehatan berperan aktif mengedukasi dan memberdayakan masyarakat agar mampu secara mandiri menjaga kesehatan, termasuk mengubah perilaku menjadi kondusif terhadap kesehatan (PHBS).
2. Preventif dan Deteksi Dini: Nakes melakukan pemantauan status kesehatan, imunisasi, perbaikan gizi, dan sanitasi dasar untuk mencegah penyakit serta mengidentifikasi risiko kesehatan di masyarakat.
3. Pelayanan Kuratif dan Rehabilitatif: Nakes (dokter, perawat, dll.) berperan dalam diagnosa, pengobatan, dan pemulihan, serta memberikan dukungan psikososial dan fasilitas akses kesehatan.
4. Penggerak Kemitraan: Tenaga kesehatan membangun kemitraan di masyarakat (seperti kader desa) untuk mengatasi masalah kesehatan lokal, serta menggerakkan partisipasi aktif masyarakat.
5. Pengembangan Kebijakan: Nakes terlibat dalam pengembangan dan penerapan kebijakan kesehatan yang berkesinambungan dan merata untuk memastikan pelayanan yang berkualitas.
6. Inovasi Layanan: Nakes mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan (contoh: posyandu prakonsepsi, layanan prioritas lansia) agar lebih efektif menjangkau kelompok rentan.

Kolaborasi lintas profesi (dokter, perawat, bidan, nutrisisionis, sanitarian) yang terintegrasi sangat penting untuk memastikan pelayanan yang menyeluruh dan tepat sasaran.

D. Peran Nakes dalam Pembangunan Kesehatan

Tenaga kesehatan bertindak sebagai penggerak dalam pembangunan kesehatan di Puskesmas maupun di tingkat komunitas (DTPK - Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan).

Sebagai satuan fungsional dalam sistem pelayanan kesehatan, Puskesmas bertugas menyelenggarakan layanan yang komprehensif, terpadu, dan dapat diterima oleh masyarakat. Pelaksanaan layanan ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat serta pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan. Sumber pembiayaan pelayanan berasal dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, dengan tujuan utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal (Lutfiana et al., 2023).

Tujuan utama dari Puskesmas adalah mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Puskesmas memainkan peran strategis dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat (Sannah N, 2017). Peningkat Kinerja Pelayanan melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan (pelatihan), nakes meningkatkan kinerja individu dan mutu pelayanan di faskes.

Pembangunan kesehatan adalah upaya komprehensif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui peningkatan kesadaran hidup sehat, pemerataan pelayanan, SDM berkualitas, infrastruktur, pembiayaan, hingga teknologi, sebagai investasi utama untuk Sumber Daya Manusia (SDM) produktif dan mendukung pembangunan nasional, Tujuannya mencakup menurunkan angka kematian, menekan kesakitan, memperbaiki gizi, dan meningkatkan usia harapan hidup, demi mewujudkan visi Indonesia Sehat. Kementerian Kesehatan RI menginisiasi transformasi kesehatan berbasis 6 pilar utama:

1. Layanan Primer: Penguatan Posyandu Prima dan Puskesmas.
2. Layanan Rujukan: Peningkatan kualitas dan aksesibilitas rumah sakit.
3. Sistem Ketahanan Kesehatan: Penanganan penyakit menular dan tidak menular, termasuk farmasi dan alat kesehatan.
4. Sistem Pembiayaan Kesehatan: Penguatan JKN dan sistem pendukungnya.
5. SDM Kesehatan: Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, seperti dokter spesialis.
6. Teknologi Kesehatan: Pemanfaatan inovasi teknologi untuk pelayanan.

E. Tantangan dan Strategi Penguatan Peran Nakes

Untuk mengoptimalkan perannya, diperlukan strategi peningkatan kualitas nakes, di antaranya distribusi dan Pelatihan untuk mengatasi ketimpangan distribusi nakes melalui program seperti Nusantara Sehat.

Sejak diluncurkan pada tahun 2015, Nusantara Sehat telah menjadi salah satu program strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengatasi

ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Program ini menempatkan tenaga kesehatan secara tim maupun individu di Puskesmas wilayah-wilayah prioritas yang selama ini minim layanan kesehatan memadai.

Program Nusantara Sehat mempunyai misi besar untuk hadir dengan misi meningkatkan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan kesehatan primer di wilayah yang sulit dijangkau. Hingga 2018, tercatat lebih dari 7.377 tenaga kesehatan telah diberangkatkan ke berbagai penjuru Nusantara. Mereka terdiri dari dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, kefarmasian, analis kesehatan, hingga tenaga kesehatan lingkungan.

Nusantara Sehat akan mengalami penguatan dan transformasi sesuai dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung 5 Pilar Transformasi Kesehatan. Beberapa arah pengembangan program mencakup:

1. Peningkatan Soft-Skills Tenaga Kesehatan

Relawan akan dibekali kemampuan komunikasi, fasilitasi masyarakat, dan pendekatan sosial budaya agar lebih efektif dalam memberikan edukasi dan pelayanan.

2. Fokus pada Promotif dan Preventif

Kegiatan penyuluhan akan diperluas tidak hanya seputar kesehatan ibu dan anak, tapi juga menyasar isu-isu seperti rokok, hipertensi, gizi buruk, keluarga berencana, dan Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Integrasi Lintas Sektor

Kemendes mendorong kolaborasi dengan sektor lain seperti pendidikan, sanitasi, teknologi informasi, hingga pemerintahan desa agar pembangunan kesehatan menjadi lebih terintegrasi.

4. Pemanfaatan Teknologi

Nusantara Sehat akan didukung digitalisasi layanan kesehatan melalui rekam medis elektronik, telekonsultasi, dan pelatihan online berbasis platform digital.

5. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Relawan juga akan ditugaskan untuk melakukan transfer pengetahuan ke kader lokal seperti kader Posyandu dan Posbindu agar layanan tetap berkelanjutan pascapenugasan.

Penguatan peran tenaga kesehatan (Nakes) di Indonesia merupakan pilar utama dalam transformasi sistem kesehatan nasional, terutama untuk mengatasi tantangan geografi, sebaran yang tidak merata, dan kebutuhan akan profesionalisme di era digital.

Berikut adalah tantangan dan strategi penguatan peran Nakes berdasarkan isu terkini:

1. Distribusi Tidak Merata (Mal-distribusi): Nakes, khususnya dokter spesialis, masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan kota besar, menyebabkan kekurangan tenaga medis di daerah terpencil dan perbatasan.
2. Kekurangan Kuantitas & Kualitas: Masih adanya krisis kekurangan tenaga medis tertentu dan ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan lapangan (kurangnya pelatihan berbasis kompetensi).
3. Beban Kerja dan *Burnout*: Nakes menghadapi beban kerja tinggi, risiko kesehatan personal, dan tekanan mental (emosional) yang tinggi, terutama pasca pandemi.
4. Adaptasi Teknologi & Data: Tantangan interoperabilitas data kesehatan dan ketidakmampuan sebagian petugas menggunakan sistem komputerisasi (digitalisasi) di layanan primer.
5. Kesejahteraan: Masalah remunerasi (tingkat penghasilan) yang dinilai belum memadai, terutama di daerah tertentu.

Strategi ini berfokus pada 6 Pilar Transformasi Kesehatan, khususnya pilar SDM Kesehatan:

1. Pemerataan Tenaga Kesehatan (Retensi & Distribusi):

- a. Mendorong kebijakan penempatan nakes di daerah terpencil melalui program intensif dan peningkatan sarana prasarana.
- b. Penguatan program *Nusantara Sehat*, *flying doctors*, dan *telehealth*.

2. Peningkatan Mutu & Kompetensi:

- a. Peningkatan pelatihan berbasis kompetensi untuk memastikan nakes taat prosedur dan berkualitas.
- b. Penargetan ribuan tenaga koder (coding) terlatih dan nakes lainnya untuk meningkatkan akurasi data dan layanan.
- c. Sosialisasi kebijakan peningkatan mutu nakes secara berkala (contoh: melalui Dirjen Nakes).

3. Penguatan Karier & Kesejahteraan (Well-being):

- a. Penerapan kebijakan *well-being* untuk mencegah *burnout* (kelelahan mental/emosional) pada nakes.
- b. Pengembangan karier dan promosi yang adil untuk meningkatkan motivasi kinerja.

4. Pemanfaatan Teknologi (Digitalisasi Kesehatan):

- a. Pelatihan nakes untuk menggunakan sistem digital (E-Puskesmas/SATUSEHAT) guna mengatasi kendala pelaporan manual.
- b. Implementasi *telemedicine* untuk memperluas jangkauan layanan nakes.

5. Penerapan UU Kesehatan (Regulasi):

- a. Mengoptimalkan UU Nakes/UU Kesehatan baru untuk mengatur perencanaan, pendidikan, pendayagunaan, dan pembinaan nakes secara terstruktur.
- b. Penyederhanaan proses STR (Surat Tanda Registrasi) yang berlaku 5 tahun.

6. Optimalisasi Peran di Layanan Primer:

- a. Penguatan peran nakes di layanan primer (puskesmas) untuk penurunan stunting, angka kematian ibu dan bayi.
- b. Peningkatan promosi kesehatan (PHBS) oleh nakes masyarakat di tingkat komunitas.

Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan nakes yang profesional, terdistribusi adil, dan sejahtera untuk mendukung visi Indonesia Maju 2045.

F. Simpulan

Tenaga kesehatan (nakes) memiliki peran strategis dan fundamental sebagai garda terdepan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kombinasi pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan masyarakat, berperan krusial dalam mengedukasi dan mengubah perilaku masyarakat menuju Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Mereka berperan aktif dalam pencegahan penyakit menular dan pemberdayaan masyarakat. Nakes bertindak sebagai penggerak masyarakat, termasuk bermitra dengan kader Posyandu dan tokoh masyarakat untuk menanggulangi masalah kesehatan seperti angka kematian ibu dan stunting. Nakes berperan sebagai penghubung (liaison) yang membantu masyarakat mengakses sumber daya kesehatan, mengedukasi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Kompetensi dan profesionalisme nakes sangat menentukan keberhasilan program pembangunan kesehatan nasional dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas manusia. Keberhasilan peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada sarana prasarana, tetapi sangat ditentukan oleh **peran aktif, dedikasi, dan kemampuan nakes** dalam melakukan intervensi kesehatan langsung di masyarakat, baik dalam bentuk pencegahan maupun edukasi.

G. Referensi

- Akbar, R., & Nasution, M. I. P. (2023). Peran Sistem Informasi Dalam Mengambil Keputusan. *Journal of Akbar, R., & Nasution, M. I. P. (2023). Peran Sistem Informasi Dalam Mengambil Keputusan. Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES), 1(3).*
- Angreni, W. O. N., Rahagia, R., Setyawati, A., Ihsan, M., & Kamaruddin, S. S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Hidup Bersih Dan Sehat Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 1-6.*
- Anugrah, S. P. 2024. Strategi Promosi Kesehatan dalam Upaya Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Masyarakat Pesisir di Wilayah Kerja Puskesmas Mangarabombang Kabupaten Takalar. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia.
- Apriyus, R. D., Hamidi, M. N. S., & Harmia, E. (2024). Perilaku Pencegahan Hipertensi Pada Masyarakat Di Desa Tarai Bangun Wilayah Kerja Upt Puskesmas Tambang Tahun 2023. *SEHAT: Jurnal Kesehatan Terpadu, 3(1), 72-82.*
- Arifah, A., Abdussamad, Z., & Igirisa, I. (2023). Implementasi Kebijakan Program Germas Di Era Pandemi Covid-19. *Normalita (Jurnal Pendidikan), 11(2).*
- Ayinun, A., Malik, I., & Haerana, H. (2023). Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 4(1), 81-95.*
- Bangun. (2020). Sehat dan Bugar di Usia Lanjut. Depok: AgroMedia
- Carolina, M., Puspita, A., & Indriana, S. (2023). Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Stunting di Desa Mantangai Hilir Puskesmas Mantangai. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan, 2(2), 50-55.*
- Chukwuere, J. E. (2021). Theoretical And Conceptual Framework: A Critical Part of Information Systems Research Process and Writing. *Review of International Geographical Education (RIGEO), 11(9), 2678-2683.*
- Darmansyah, I. (2025). Sistem Informasi Persediaan Barang Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara. *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi, 3(1), 169-177.*
- Dewi, S. C. S. (2021). Pengetahuan Mempengaruhi Motivasi Keluarga Dalam Pelaksanaan GERMAS. *Jurnal Delima Harapan, 8(2), 26-33.*

Dimyati A. (2017). Hubungan Informasi Materi Penyuluhan dengan Sosialisasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), 1–20.

Febrilia, W., Jummi, C. V. R., & Diah, H. (2023). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Nandong Smong di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 8(2), 193-206.

H. Glosarium

WHO = *World Health Organization*

UUD = Undang-Undang Dasar

Nakes = Tenaga Kesehatan

SDM = Sumber Daya Manusia

CHAPTER 3

KONTRIBUSI KEBIDANAN TERHADAP PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Ayu Mustika Handayani, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan / Prolog

Bidan adalah bagian penting dari perawatan kesehatan masyarakat. Perannya tidak hanya membantu proses persalinan, tetapi juga memberikan pendidikan, membantu orang menemukan risiko kesehatan yang lebih awal, dan memberikan pendampingan yang berkelanjutan. Akibatnya, kehadiran bidan sangat penting untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia serta meningkatkan kualitas hidup keluarga (Aizan, 2025b).

Bidan memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, terutama selama kehamilan, persalinan, dan setelah persalinan. menyatakan bahwa bidan adalah tenaga medis profesional yang terlatih memberikan layanan menyeluruh kepada ibu dan bayi baru lahir, termasuk dalam merencanakan keluarga berencana (KB). Mereka bukan hanya profesional medis, tetapi juga pendamping emosi yang memastikan kehamilan dan persalinan aman dan selamat. Lebih dari 70% layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di daerah di Indonesia ditangani oleh bidan. Ini menunjukkan peran penting mereka dalam mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), yang masing-masing tercatat sebesar 189 per 100.000 dan 16 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2022 (Aditya, 2025).

Pembangunan kesehatan nasional sangat bergantung pada kesehatan ibu dan anak. Tujuan dari peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak adalah untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Sebagai tenaga medis terdepan, bidan bertanggung jawab untuk memberikan persalinan yang aman dan berkualitas serta mengatasi berbagai komplikasi yang mungkin muncul selama kehamilan dan setelah persalinan (LDP Ikatan Bidan Indonesia, 2025).

Komplikasi persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu adalah masalah utama yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan ibu. Penyebab utama kematian ibu termasuk perdarahan, infeksi, hipertensi kehamilan, dan penyakit jantung, yang semua berpotensi membahayakan ibu dan janin. Penyakit jantung pada ibu hamil di Indonesia sangat umum dan memerlukan perhatian khusus. Kondisi ini diperparah karena di beberapa daerah tidak ada dokter jantung yang tersedia, yang membuat

peran bidan sangat penting untuk mengidentifikasi dan merujuk kasus (LDP Ikatan Bidan Indonesia, 2025).

Menghormati dan mendukung profesi bidan juga berarti berinvestasi pada masa depan negara karena mereka adalah pilar utama dalam menjamin hak kesehatan bagi ibu dan anak. Menurut International Confederation of Midwives, "Setiap ibu harus memiliki seorang bidan, dan setiap bidan harus menerima penghormatan." Bidan dapat menjalankan peran mereka dengan lebih baik dalam menurunkan angka kematian, meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak, dan membangun generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting dengan meningkatkan kapasitas, distribusi yang lebih merata, dan dukungan teknologi dan kebijakan (Aditya, 2025).

B. Peran Penting Bidan dalam Menjaga Kesehatan Ibu dan Anak

Bidan sangat penting untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di berbagai masyarakat. Bidan adalah orang pertama yang memastikan kesehatan optimal bagi ibu dan anak karena mereka adalah tenaga medis yang berfokus pada perawatan kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan. Mereka tidak hanya memainkan peran penting dalam proses melahirkan, tetapi juga menawarkan dukungan dan pelatihan kesehatan kepada ibu hamil dan keluarga mereka (Kurnia, 2024).

Salah satu program prioritas nasional yang berkelanjutan adalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Tujuannya tidak hanya mencegah AKI dan AKB, tetapi juga melindungi hak perempuan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman serta meningkatkan kualitas pertumbuhan anak melalui gizi seimbang, imunisasi, dan pengawasan perkembangan. Sebagian besar, di puskesmas pembantu atau posyandu di lapangan, bidan adalah satu-satunya tenaga kesehatan, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Namun, mereka menghadapi banyak masalah. Alat medis yang terbatas, distribusi yang tidak merata, beban kerja yang tinggi, dan kurangnya akses ke pelatihan lanjutan adalah semua masalah yang sering menghalangi mereka untuk melakukan tugas profesional mereka (Aditya, 2025).

Peran bidan sangat penting dalam sistem kesehatan, terutama dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Pekerjaan bidan mencakup seluruh siklus reproduksi perempuan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, hingga masa menyusui dan perawatan bayi baru lahir. Bidan memiliki peran penting sebagai penyedia kesehatan utama yang dekat dengan masyarakat, membantu kesehatan ibu dan anak dengan memberikan layanan komprehensif mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi, termasuk deteksi risiko, edukasi gizi dan KB, imunisasi,

dan pendampingan psikologis. Mereka juga menjadi garda terdepan dalam pengurangan AKI/AK dan stunting, khususnya di daerah pedesaan (Aizan, 2025a).

Bidan pedesaan berperan dalam menyediakan beberapa layanan kesehatan primer yang diamanatkan oleh pemerintah dan profesi. Mereka juga menawarkan layanan kesehatan di luar lingkup mereka sebagai bidan karena kesulitan geografis dan masalah logistik. Temuan ini memberikan informasi kepada pembuat kebijakan untuk meninjau dan mengubah peran bidan yang lebih luas sehingga mereka diberdayakan dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan legal (Felipe-Dimog et al., 2023).

C. Kontribusi Utama Bidan Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak

Kontribusi utama bidan terhadap peningkatan Kesehatan ibu dan anak adalah:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu:

a. Antenatal Care (ANC)

Melakukan pemeriksaan kehamilan rutin, memberi tahu orang tentang nutrisi dan gaya hidup sehat, dan mendeteksi komplikasi pada waktunya. Pelayanan antenatal (ANC) adalah pemeriksaan medis rutin selama kehamilan yang memerlukan minimal enam pemeriksaan untuk memantau kesehatan fisik dan mental ibu dan janin. ANC sangat penting untuk mendeteksi komplikasi, mencegah kematian ibu dan bayi, memastikan perkembangan janin, dan mengajarkan tentang persiapan persalinan, nifas, dan ASI eksklusif (Mariza & Isnaini, 2022). Peran ANC Terhadap Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak adalah:

1) Pemantauan Kesehatan Rutin

Dokter dan bidan dapat melacak kondisi ibu dan perkembangan janin melalui pemeriksaan fisik, USG, dan laboratorium (10T).

2) Deteksi Komplikasi Dini

Cari tanda-tanda risiko tinggi seperti anemia, preeklampsia, atau KEK untuk penanganan cepat.

3) Pencegahan Penyakit

Ibu dan bayi harus diberi imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dan suplemen gizi dalam bentuk tablet darah.

4) Persiapan Persalinan dan Nifas

Ketahui cara persalinan aman, persiapan eksklusif untuk menyusui, dan perawatan pasca melahirkan untuk menghindari baby blues.

5) Kesehatan Mental Ibu

Mengawasi masalah psikologis yang timbul selama kehamilan

Di Indonesia, standar pelayanan antenatal (ANC) mencakup standar 10T, yang berfokus pada deteksi dini risiko kehamilan, pemenuhan gizi, dan persiapan persalinan aman. Standar ini mencakup minimal 6 kali pemeriksaan USG oleh dokter selama trimester pertama, dua kali trimester kedua, dan tiga kali trimester ketiga (Tarmizi, 2023). Berikut adalah poin-poin penting standar pelayanan ANC (10T/12T):

- 1) Timbang Berat Badan dan Ukur Tinggi Badan: Memantau kenaikan berat badan.
- 2) Ukur Tekanan Darah: Mendeteksi hipertensi/preeklamsia.
- 3) Ukur Lingkar Lengan Atas (LiLA): Skrining Kurang Energi Kronis (KEK).
- 4) Ukur Tinggi Fundus Uteri: Memantau pertumbuhan janin
- 5) Tentukan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ): Memastikan posisi dan kesehatan janin.
- 6) Skrining Status Imunisasi Tetanus (TT): Imunisasi TT jika diperlukan.
- 7) Tablet Tambah Darah (Fe): Minimal 90 tablet selama hamil.
- 8) Tes Laboratorium: Meliputi Hemoglobin (Hb), Golongan Darah, Tes HIV, Sifilis, dan Hepatitis B (Triple Eliminasi).
- 9) Tata Laksana Kasus/Penanganan: Tindak lanjut jika ditemukan masalah.
- 10) Temu Wicara (Konseling): Edukasi gizi, persiapan persalinan, KB, dan kesehatan jiwa.
- 11) USG (Dokter): Dilakukan minimal 2 kali (trimester 1 dan 3).

b. Persalinan

Mendampingi persalinan yang aman dan nyaman, dan mengidentifikasi gejala komplikasi untuk rujukan. Selain memastikan proses kelahiran yang aman, fisiologis, dan nyaman, ibu juga memantau tanda vital ibu dan janin untuk mengidentifikasi komplikasi dini. Untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak, mereka memberikan dukungan emosional, melakukan manajemen aktif kala tiga, memberikan asuhan nifas, dan merujuk kasus berisiko tinggi (Wati et al., 2025). Sebagai bagian dari proses persalinan, berikut adalah peran bidan sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan anak:

1. Pemantauan dan Asuhan Persalinan Aman:

Bidan melacak kontraksi, posisi janin, dan tanda vital ibu untuk mengidentifikasi komplikasi dini. Mereka memiliki otoritas untuk menjahit luka jalan lahir dan melakukan episiotomi jika diperlukan.

2. Pendekatan Psikologis dan Emosional:

Bidan memberikan dukungan fisik dan emosional untuk mengurangi ketakutan, meningkatkan kepercayaan diri ibu, dan memberikan pengalaman melahirkan yang positif.

3. Tindakan Medis Darurat dan Rujukan:

Bidan melakukan persalinan normal dan melakukan tindakan pertolongan pertama jika ada risiko atau komplikasi, seperti perdarahan berat.

4. Perawatan Bayi Baru Lahir:

Bidan membantu proses persalinan, melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), dan memberikan perawatan dasar bayi.

5. Perawatan Nifas dan Menyusui:

Bidan mengurus nifas, memantau perdarahan, memberikan vitamin A, dan membantu ibu menyusui dan merawat bayinya.

6. Edukasi dan Keluarga Berencana (KB):

Bidan memberikan informasi tentang perencanaan keluarga, perawatan kesehatan ibu dan bayi, dan KB setelah persalinan.

c. Pascapersalinan (Nifas):

Bidan memantau kondisi kesehatan ibu, membantu proses laktasi (menyusui), dan memberikan perawatan kepada nifas. Pasca persalinan, ibu memiliki peran penting dalam memantau kesehatan ibu (nifas) dan bayi baru lahir, termasuk deteksi komplikasi dini, perawatan luka, dukungan menyusui (IMD), instruksi perawatan bayi, dan konseling KB. Bidan juga memastikan pemulihan fisik dan psikologis ibu, pertumbuhan bayi, dan pengurangan angka kematian ibu dan anak melalui kunjungan nifas yang terorganisir (AKPA, 2024).

2. Pelayanan Kesehatan Anak

Sebagai garda terdepan di fasilitas primer (Puskesmas atau Posyandu), ibu memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan anak, termasuk merawat bayi baru lahir, mengawasi perkembangan mereka, memberikan vaksinasi, dan mengajarkan gizi. Bidan juga bertugas mengidentifikasi risiko kesehatan, melakukan intervensi, dan menangani komplikasi untuk mengurangi angka kematian bayi dan balita (Aizan, 2025a).

a. Bayi Baru Lahir: Memberikan perawatan bayi, bimbingan menyusui, dan imunisasi dasar.

b. Tumbuh Kembang Anak: Memberikan instruksi kepada orang tua dan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita.

c. Pencegahan Penyakit: Memberikan imunisasi dasar dan pendidikan pencegahan penyakit.

3. Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (KB)

Penyuluhan kesehatan reproduksi, konseling pra-nikah dan KB, dan layanan kontrasepsi untuk perencanaan kehamilan yang matang (mencegah 4T: terlalu muda, tua, dekat, atau banyak).

Melalui melakukan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif, ibu berperan sebagai garda terdepan dalam perawatan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana (KB). Konseling (KIE), pemasangan alat kontrasepsi (MKJP), pelatihan kesehatan reproduksi remaja, dan layanan medis untuk ibu mulai dari masa pra-konsepsi, kehamilan, nifas, dan menyusui adalah bidang yang sangat penting (Juwitia et al., 2023).

4. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Menjadikan bidan sebagai motivator kesehatan di komunitasnya dengan memberikan penyuluhan tentang kesehatan ibu dan anak, nutrisi, kebersihan, dan pentingnya pemeriksaan dini.

Bidan sangat penting sebagai pendidik dan fasilitator pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam hal kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat. Untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, mereka menerapkan edukasi kesehatan, deteksi dini risiko, dan pendampingan, serta menggerakkan kader kesehatan, seperti Posyandu dan Desa Siaga (Prodi Kebidanan, 2024). Peran Bidan dalam Pendidikan Masyarakat diantaranya adalah (Baghini et al., 2023):

a. Penyuluh Kesehatan

Memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, nifas, laktasi, gizi seimbang, dan pencegahan penyakit menular seperti stunting dan anemia.

b. Konselor

Memberikan konseling individu dan kelompok tentang KB, pola asuh, dan perawatan bayi baru lahir.

c. Pendidik

Mengajarkan tentang sanitasi lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Peran Bidan dalam Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai Penggerak Desa Siaga, dengan membantu mendirikan desa siaga, mengelola Dana Sehat/Tabulin (Tabungan Ibu Bersalin), dan menyediakan ambulans desa. Fasilitator dan Motivator: Melatih staf kesehatan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam posyandu, serta memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan tentang kesehatan reproduksi. Koordinator: Berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan fasilitas kesehatan terdekat (Handayani, 2017).

5. Deteksi dan Rujukan Dini

Mampu mengidentifikasi ibu dan bayi yang rentan dan segera merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

Bidan adalah garda terdepan dalam kesehatan ibu dan anak (KIA) melalui pelayanan antenatal (ANC) rutin, deteksi dini risiko tinggi atau komplikasi kehamilan, persalinan aman, dan pemantauan nifas. Bidan juga mengidentifikasi kelainan genetik, stunting, dan perkembangan anak, dan merekomendasikan rujukan segera ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi (Anjani et al., 2025).

Peran bidan dalam deteksi dan rujukan KIA adalah sebagai berikut (Baghini et al., 2023):

a. Deteksi Dini Risiko Kehamilan Tinggi

Bidan melakukan skrining pada ibu hamil, yang mencakup pemeriksaan darah, tes kehamilan, dan USG untuk memantau kesehatan ibu dan janin.

b. Deteksi Tanda Bahaya Nifas dan Bayi

Menjaga tanda-tanda komplikasi nifas, infeksi, anemia, dan depresi pascamelahirkan. Selain itu, bidan menggunakan SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang) di posyandu untuk mendeteksi kelainan tumbuh kembang anak sejak dini.

c. Asisten Persalinan dan Rujukan

Jika terjadi komplikasi selama persalinan, ibu hamil segera dirujuk ke rumah sakit.

d. Pendidikan dan Pemberdayaan

Memberikan instruksi tentang nutrisi, kebersihan, dan perencanaan keluarga (KB) untuk mengurangi komplikasi sejak dini.

e. Fasilitator Kesehatan

Bidan seringkali satu-satunya tenaga medis di daerah terpencil yang dapat menjamin proses persalinan yang aman, bersih, dan tepat sasaran.

D. Peran Bidan di Masyarakat

1. Garda Terdepan

Bidan seringkali menjadi satu-satunya tenaga medis yang tersedia, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan terluar). Bidan adalah pusat dan ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di masyarakat, terutama di daerah terpencil. Mereka sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, memungkinkan orang mendeteksi risiko kehamilan terlebih dahulu, menyediakan layanan persalinan, dan memberikan pendidikan tentang nutrisi yang baik untuk mencegah stunting (Susilawati et al., 2022). Peran Strategis Bidan sebagai Garda Terdepan adalah:

a. Pelayanan Kesehatan Primer (Promotif & Preventif)

Bidan mengajarkan nutrisi, mempromosikan kesehatan, dan menunjukkan tanda bahaya kehamilan. Mereka juga mendampingi perempuan sepanjang

siklus hidup mereka (remaja, hamil, persalinan, dan nifas). Bidan aktif mengidentifikasi risiko kehamilan yang tinggi dan merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap jika diperlukan untuk keselamatan ibu dan bayi.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Bidan membantu kader dan tokoh masyarakat meningkatkan kesehatan komunitas.

c. Penanganan Stunting

Untuk mencegah stunting sejak dini, ibu hamil harus mengajarkan anak mereka tentang gizi seimbang dan ASI eksklusif.

2. Pendekatan Holistik

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan menetapkan bahwa bidan memberikan asuhan kebidanan yang menyeluruh, humanistik, dan berdasarkan bukti dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor fisik, psikologi, emosional, sosial budaya, spiritual, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Pendekatan ini juga mencakup upaya pencegahan, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang sesuai dengan kebutuhan (Menkes RI, 2020). Selain layanan medis, memberikan dukungan emosional dan psikologis, membangun kepercayaan keluarga.

Berikut adalah Komponen Pelayanan Holistik Bidan yang menerapkan pendekatan holistik dengan melihat setiap orang secara utuh (NMC, 2024):

a. Aspek Fisik dan Medis

Pemeriksaan kehamilan, prosedur persalinan yang aman, perawatan nifas, dan perawatan bayi baru lahir.

b. Aspek Sosial & Budaya

Memahami konteks sosial dan budaya lokal dalam asuhan, termasuk melibatkan keluarga (pendekatan keluarga).

c. Aspek Spiritual

Menghormati kepercayaan ibu dan keluarga tentang kesehatan.

d. Aspek Emosional & Psikologis

Memberikan dukungan psikologis untuk mengurangi kecemasan ibu selama kehamilan dan persalinan.

e. Penggunaan Metode Komplementer

Meningkatkan kenyamanan dengan menggabungkan teknik alami seperti pijat nifas, yoga, aromaterapi, atau teknik relaksasi (Umami et al., 2023).

Metode Holistik ini sesuai dengan standar asuhan kebidanan yang menekankan pelayanan yang humanis, berdasarkan bukti, dan mempertimbangkan semua kebutuhan pasien. Keunggulan Metode Holistik di Masyarakat adalah:

a. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Metode ini meningkatkan kesehatan ibu dan bayi secara efektif dalam jangka panjang.

b. Pelayanan yang Berpusat pada Perempuan (Woman-Centered Care)

c. Memungkinkan ibu untuk membuat pilihan yang diinformasikan (informed choice) tentang kesehatan mereka sendiri.

d. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Penggunaan strategi komprehensif dapat mengurangi risiko.

e. Aksesibilitas Lebih Baik

Bidan yang tinggal di komunitas membantu ibu lebih dekat dengan layanan kesehatan, yang mengurangi hambatan geografis (Marbun et al., 2021).

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk mencegah stunting dan masalah kesehatan lainnya di masa depan. Bidan memiliki peran krusial dan strategis dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sebagai garda terdepan di masyarakat. Peran ini diwujudkan melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) secara berkesinambungan, mulai dari masa pra-konsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga tumbuh kembang bayi (Aizan, 2025a). Berikut adalah peran bidan sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kualitas SDM:

a. Gardia Terdepan Penurunan AKI dan AKB (Kesehatan Dasar)

1) Pengawal Keselamatan Ibu dan Bayi

Bidan adalah orang pertama yang mendampingi ibu hamil hingga persalinan, dan peran mereka sangat penting dalam menurunkan AKI dan AKB

2) Deteksi Dini Risiko Tinggi

Untuk mencegah komplikasi kehamilan yang dapat menghentikan perkembangan janin, ibu hamil melakukan pemantauan intensif, juga dikenal sebagai antenatal care (Aizan, 2025b).

b. Ujung Tombak Pencegahan Stunting

1) Intervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Untuk mencegah stunting, atau kekurangan gizi kronis, yang berdampak pada kualitas kognitif SDM di masa depan, ibu hamil harus memperhatikan gizi ibu hamil dan memantau perkembangan anak mereka.

2) Edukasi Gizi dan ASI Eksklusif

Selama enam bulan, bidan membantu ibu hamil dengan nutrisi yang tepat (Susilawati et al., 2022).

c. Edukator dan Pemberdaya Masyarakat

1) Pendidik Kesehatan (Pendidik)

Bidan mengajarkan masyarakat tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga (KB), pola asuh anak, dan kesehatan gizi.

2) Fasilitator Pemberdayaan: Bidan mendorong kader dan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam posyandu dan menciptakan lingkungan yang sehat (Rosmiati, tri anonim, 2016).

d. Garda Terdepan di Pelosok (Aksesibilitas)

Bidan desa atau bidan di fasilitas kesehatan primer adalah tumpuan utama masyarakat, seringkali harus menembus medan sulit untuk memberikan layanan Kesehatan (Aizan, 2025b).

Oleh karena itu, kualitas SDM yang unggul dimulai dengan kesehatan yang terjaga sejak dalam kandungan, di mana bidan adalah orang yang paling penting untuk menjamin bahwa proses itu aman dan sehat.

E. Tantangan dan Permasalahan Utama Bidan di Masyarakat

Tren praktik kebidanan saat ini adalah hasil dari kombinasi kemajuan teknologi, kebijakan kesehatan yang lebih progresif, dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Kualitas perawatan kebidanan diharapkan semakin meningkat, memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan anak di seluruh dunia.

Teknologi medis telah membawa perubahan besar dalam praktik kebidanan sebagai komponen perkembangan teknologi dalam kebidanan. Dengan alat diagnostik canggih seperti ultrasonografi (USG) 3D dan 4D, masalah dan perkembangan janin dapat dideteksi lebih awal. Perangkat monitor jantung janin yang lebih canggih juga dapat digunakan untuk memantau kesehatan janin selama persalinan. Kebidanan juga mulai menggunakan teknologi telemedicine, yang memungkinkan bidan memberikan konsultasi dan pemantauan jarak jauh kepada ibu hamil yang tinggal di daerah terpencil.

Praktik kebidanan masih menghadapi banyak masalah meskipun banyak kemajuan telah dicapai. Ketimpangan dalam layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan merupakan salah satu masalah utama. Rumah sakit dan tenaga kebidanan yang terlatih masih kekurangan di banyak wilayah terpencil. Perubahan sosial dan budaya juga berdampak pada penerimaan dan pelaksanaan praktik kebidanan kontemporer.

Beberapa masalah utama yang dihadapi bidan di masyarakat, terutama di daerah terpencil, adalah ketersediaan fasilitas yang terbatas, kesulitan untuk mencapai lokasi geografis, dan kepercayaan masyarakat terhadap dukun. Layanan kesehatan ibu dan anak yang baik juga dihambat oleh beban kerja tinggi, kurangnya tenaga kesehatan, dan tingkat kompensasi yang rendah. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa setiap ibu dan anak mendapatkan perawatan terbaik, perlu ada upaya berkelanjutan untuk mengatasi masalah-masalah ini.

1. Permasalahan bidan di daerah terpencil

Hambatan sosial dan budaya, ekonomi dan profesional yang signifikan dapat mencegah penyediaan layanan kebidanan berkualitas di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (Filby et al., 2016). Hambatan dan permasalahan utama bidan di masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, meliputi keterbatasan sarana/prasarana, akses geografis yang sulit, kurangnya obat-obatan, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat faktor budaya. Masalah ini diperberat dengan beban kerja tinggi, kurangnya jaminan keamanan, dan kompensasi yang belum memadai. Berikut adalah beberapa hambatan dan permasalahan utama bidan di masyarakat:

a. Fasilitas dan Sarana Kesehatan Minimal

Bidan seringkali bekerja dengan peralatan yang tidak memadai di tempat praktik yang tidak memadai, dan mereka tidak memiliki obat-obatan yang penting.

b. Akses Geografis dan Transportasi

Kerusakan jalan, bahaya, atau jarak yang jauh ke rumah pasien (terutama selama musim hujan) menghambat pelayanan.

c. Masalah Sosial dan Budaya

Tradisi yang masih ada, kepercayaan pada dukun beranak, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan membuatnya sulit untuk mengetahui risiko kehamilan sebelum hamil.

d. Kurangnya Keamanan dan Beban Kerja

Bidan sering menghadapi risiko keamanan seperti pelecehan verbal atau fisik, beban kerja yang tinggi tanpa didukung fasilitas aman, dan tanggung jawab yang tinggi tanpa kompensasi yang layak.

e. Keterbatasan SDM dan Kompetensi

Ada kekurangan bidan di daerah tertentu, dan perlunya keterampilan yang lebih baik dalam menggunakan teknologi digital.

f. Kepatuhan Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program kesejahteraan.

2. Permasalahan bidan dalam transformasi digital

Untuk mengikuti transformasi digital dalam dunia kesehatan, tenaga kesehatan, termasuk bidan, harus memiliki kemampuan digital yang lebih baik. Teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), dan big data mendukung era kesehatan 5.0 dengan fokus pada pendekatan yang berpusat pada manusia. Penggunaan teknologi dasar seperti aplikasi e-Kohort dan sistem informasi kesehatan ibu dan anak (SIKIA) masih membatasi kemampuan digital bidan. Pengembangan pelatihan berkelanjutan, peningkatan kurikulum digital dalam pendidikan kebidanan, dan penyediaan platform pembelajaran digital adalah beberapa langkah yang disarankan. Peningkatan kemampuan digital bidan juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan integrasi teknologi dalam sistem pelayanan kebidanan (Dewi et al., 2025).

Solusi penting untuk mengatasi masalah ini adalah kolaborasi lintas sektor, peningkatan sarana prasarana, dan pendekatan persuasif berbasis budaya (Adatara et al., 2021). Diperlukan tindakan yang terkoordinasi di tingkat regional dan nasional untuk menarik dan mempertahankan bidan serta memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan lingkup praktik mereka sepenuhnya. Tindakan ini mencakup:

- a. Menyediakan program pendidikan kebidanan yang memenuhi standar internasional,
- b. Memprioritaskan dan menegakkan kebijakan yang memberikan kompensasi yang memadai bagi bidan, dan
- c. Melibatkan asosiasi bidan dalam perencanaan dan kebijakan tentang tenaga kerja kebidanan, dan
- d. Memastikan bahwa lingkungan kerja bidan aman dan dilengkapi dengan baik (Bogren et al., 2020).

Untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak (KIA) di masyarakat, bidan dapat meningkatkan kompetensi klinis, memanfaatkan teknologi digital, bekerja sama lintas sektoral dan kemitraan dukun bayi, meningkatkan promosi kesehatan preventif dan promotif, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat (Atmojo et al., 2025).

- a. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme (Tantangan: Keterbatasan Keterampilan/Pengetahuan)
 - 1) Pendidikan Berkelanjutan
Untuk mempertahankan kompetensi mereka, bidan harus berpartisipasi dalam pelatihan, kursus penyegaran, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan.
 - 2) Peningkatan Kemampuan (Advokasi)

Jika mereka ingin mempengaruhi pembuat kebijakan lokal, bidan harus meningkatkan keterampilan komunikasi dan advokasi mereka.

3) Improvisasi dan Motivasi

Tumbuhkan dorongan dalam diri Anda untuk beradaptasi dengan kekurangan fasilitas dan beradaptasi dengan layanan darurat.

b. Penguatan Pelayanan Kesehatan Komunitas (Tantangan: Akses dan Fasilitas)

1) Kemitraan Dukun Bayi

Membangun kemitraan dengan dukun bayi tradisional untuk merujuk persalinan ke fasilitas kesehatan, bukan menghilangkannya.

2) Optimalisasi Layanan Desa

Gunakan posyandu, kelas ibu hamil, dan kunjungan rumah untuk edukasi kesehatan dengan lebih baik.

3) Penggunaan Teknologi Digital

Memanfaatkan aplikasi/media sosial untuk edukasi kesehatan, pelacakan kehamilan, dan jadwal imunisasi agar jangkauan lebih luas.

c. Pemberdayaan Masyarakat dan Lintas Sektoral (Tantangan: Budaya/Sosial)

1) Edukasi Berbasis Budaya

Memberikan penyuluhan dengan cara yang sesuai dengan kearifan lokal.

2) Kerja Sama Lintas Sektor

Berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, kader, dan pemerintah desa untuk mendukung program kesehatan, termasuk penanganan stunting.

d. Solusi untuk Sarana dan Prasarana (Tantangan: Fasilitas Minim)

1) Advokasi Anggaran

Bidan desa harus mendorong pemerintah desa atau daerah untuk meningkatkan fasilitas dan obat-obatan di tempat praktik.

2) Optimalisasi Sumber Daya

Gunakan fasilitas yang ada di lingkungan Anda untuk memberikan pelayanan yang aman (Atmojo et al., 2025).

F. Simpulan

Dengan menyediakan layanan komprehensif mulai dari kehamilan hingga perawatan setelah persalinan, bidan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Mereka tidak hanya membantu proses persalinan, tetapi mereka juga memberi tahu orang-orang tentang risiko kesehatan, nutrisi, dan dukungan emosi. Mayoritas bidan menangani lebih dari 70% layanan kesehatan ibu dan anak, yang berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi. Mereka sering menghadapi masalah penting terkait persalinan, seperti perdarahan dan hipertensi kehamilan. Bidan harus siap menghadapi masalah seperti keterbatasan

alat dan akses ke pelatihan lanjutan sebagai penyedia layanan kesehatan yang sering kali satu-satunya di daerah terpencil. Program kesehatan ibu dan anak bertujuan untuk mengurangi kematian melalui perawatan antenatal yang rutin, persiapan persalinan yang aman, dan dukungan setelah melahirkan.

G. Referensi

- Adatara, P., Amooba, P. A., Afaya, A., Salia, S. M., Avane, M. A., Kuug, A., Maalman, R. S. E., Atakro, C. A., Attachie, I. T., & Atachie, C. (2021). Challenges experienced by midwives working in rural communities in the Upper East Region of Ghana: a qualitative study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03762-0>
- Aditya, F. (2025). *Peran Vital Bidan dalam Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia*. Beritaunsoed.Com. <https://beritaunsoed.com/2025/06/24/peran-vital-bidan-dalam-kesehatan-ibu-dan-anak-di-indonesia/#:~:text=Tujuannya tidak hanya untuk menekan,%2C cerdas%2C dan bebas stunting>
- Aizan, S. (2025a). *Mengenal Peran Bidan dalam Menjaga Kesehatan Ibu dan Anak*. FKIK Kebidanan, Universitas Alma Ata. <https://kebidanan.almaata.ac.id/mengenal-peran-bidan-dalam-menjaga-kesehatan-ibu-dan-anak/#:~:text=Pelayanan yang diberikan bertujuan untuk,masyarakat dengan hati dan kompetensi>
- Aizan, S. (2025b). *Peran Bidan dalam Menjaga Kesehatan Ibu dan Bayi Sejak Masa Kehamilan*. FKIK Kebidanan, Universitas Alma Ata. <https://kebidanan.almaata.ac.id/peran-bidan-dalam-menjaga-kesehatan-ibu-dan-bayi-sejak-masa-kehamilan/#:~:text=Bidan merupakan pilar penting dalam,meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia>
- AKPA. (2024). *Mengenal Fungsi Bidan: Dari Persiapan Hingga Persalinan, Kunci Kelancaran Ibu Melahirkan*. Akademi Kebidanan Prestasi Agung. <https://akbidpresagung.ac.id/mengenal-fungsi-bidan-dari-persiapan-hingga-persalinan-kunci-kelancaran-ibu-melahirkan/>
- Anjani, A. D., Lestari, D., Aulia, N., & Syaira, M. (2025). *Edukasi Dan Konseling Reproduksi*. 9(5), 4424–4430.
- Atmojo, J. T., Rini, C. S., & Lieskusumastuti, A. D. (2025). *INOVASI PROMOSI KESEHATAN DALAM KEBIDANAN* (A. Widiyanto, H. Prasetya, & B. Murti (eds.)). Tahta Media Group.
- Baghini, F. K., Iranifard, E., Roudsari, R. L., & Najmabadi, K. M. (2023). The Role of

Midwives in Women's Empowerment: A Narrative Review. *Journal of Midwifery and Reproductive Health*, 11(3), 3767–3781. <https://doi.org/10.22038/JMRH.2022.68761.2016>

- Bogren, M., Grahn, M., Kaboru, B. B., & Berg, M. (2020). Midwives' challenges and factors that motivate them to remain in their workplace in the Democratic Republic of Congo - an interview study. *Human Resources for Health*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12960-020-00510-x>
- Dewi, Gustiani, R., & Dwi Treasa, A. (2025). Strategi Peningkatan Kompetensi Digital Bidan dalam Era Kesehatan 5.0. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 11068–11074. <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/2893>
- Felipe-Dimog, E. B., Liang, F. W., Tumulak, M. A. J. R., Hsu, M. T., Sia-Ed, A. B., & Dumalhin, Y. J. B. (2023). Roles and Functions of Rural Health Midwives in Cordillera Administrative Region: A Qualitative Pilot Study. *Acta Medica Philippina*, 57(6), 5–17. <https://doi.org/10.47895/amp.vi0.5326>
- Filby, A., McConville, F., & Portela, A. (2016). What prevents quality midwifery care? A systematic mapping of barriers in low and middle income countries from the provider perspective. *PLoS ONE*, 11(5), 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153391>
- Handayani, F. (2017). Penguatan Peran Bidan Dalam Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 2(2)(2), 13–18.
- Juwitia, Argaheni, N. B., Setiyowati, A., Susilawati, D. W., Widiyatik, I., & Sabekti, T. (2023). *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian Reproduksi Ibu Melalui Program Safari Kb. 2022*, 1160–1168.
- Kurnia, A. (2024). *Peran Vital Bidan dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak*. <https://ehealth.co.id/blog/post/peran-vital-bidan-dalam-meningkatkan-kesehatan-ibu-dan-anak/>
- LDP Ikatan Bidan Indonesia. (2025). *Transformasi Layanan Kesehatan Ibu dan Anak dalam Memperkuat Peran Bidan sebagai Garda Terdepan*. Kemenkes RI. <https://lms.kemkes.go.id/courses/fcf085f3-15f5-49c5-b67d-6cdf2d62d891>
- Marbun, M., Erhan, K. I., Sahfitri, A., & Efarina, U. (2021). Model Asuhan Kebidanan Berbasis Komunitas untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Perempuan dan Anak. *MUARA (Multidisiplin Paradigma Journal)*, 6.
- Mariza, A., & Isnaini, N. (2022). PENYULUHAN PENTINGNYA ANTENATAL CARE

SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN IBU HAMIL. *Jurnal Perak Malahayati: Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 4, 223–233.

Menkes RI. (2020). *KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/320/2020 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN*.

NMC. (2024). *Holistic care*. Nursing & Midwifery Council. <https://www.nmc.org.uk/standards/guidance/holistic-care/#:~:text=Caroline,holistic care in the community>.

Prodi Kebidanan, S. M. H. (2024). *Mengenal Peran dan Fungsi Bidan dalam kehidupan Masyarakat*. <https://stikesmalukuhusada.ac.id/kebidanan/?artikel=mengenal-peran-dan-fungsi-bidan-dalam-kehidupan-masyarakat#:~:text=Bidan juga memainkan peran besar,melalui pendekatan kesehatan berbasis komunitas>.

Rosmiati, tri anonim, S. (2016). *Peran Bidan Dalam Pelaksanaan Program Perencanaan*. 10, 70–79.

Susilawati, E., Yanti, E. and, Helina, Y. and S., & Siska. (2022). *Bidan, ASI Eksklusif, Dan Stunting Peran Bidan Sebagai Garda Terdepan Pendukung Keberhasilan ASI Eksklusif Pada Ibu Menyusui Sebagai Langkah Pencegahan Stunting*. Taman Karya.

Tarmizi, S. N. (2023). *Turunkan Angka Kematian Ibu melalui Deteksi Dini dengan Pemenuhan USG di Puskesmas*. Kemenkes RI. <https://kemkes.go.id/id/turunkan-angka-kematian-ibu-melalui-deteksi-dini-dengan-pemenuhan-usg-di-puskesmas#:~:text=Kementerian Kesehatan RI menetapkan pemeriksaan ibu hamil,untuk penyediaan layanan esensial bagi Ibu hamil>.

Umami, N., Farahdiba, Argaheni, N. B., Alvionita, V., Sari, P. I. A., Anggraini, Y., Petricka, G., Wulandari, U. R., & Zuhrotunida. (2023). *Pelayanan Holistik dalam Praktik Kebidanan. PT Global Eksekutif Teknologi*.

Wati, I., Suhartati, S., Devin, D., & Arbiyah, A. (2025). Peran Bidan dalam Mendukung Persalinan Aman dan Nyaman. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 8538–8544. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3250>

H. Glosarium

AKB = Angka Kematian Bayi

AKI = Angka Kematian Ibu

ANC = *Antenatal Care*

Baby blues = Perasaan sedih, cemas, mudah marah, dan kewalahan yang dialami banyak ibu baru setelah melahirkan, biasanya muncul dalam 2-3 hari pasca-persalinan dan mereda dalam 1-2 minggu, disebabkan oleh perubahan hormon drastis, kelelahan, dan stres adaptasi.

Episiotomi = Prosedur bedah berupa sayatan kecil pada perineum (area antara vagina dan anus) yang dilakukan saat persalinan normal untuk memperlebar jalan lahir

KB = Keluarga Berencana

KEK = Kurang Energi Kronis

KIE = Komunikasi, Informasi dan Edukasi

USG = Ultrasonografi

WHO = World Health Organization



CHAPTER 4

PERAN KEPERAWATAN DALAM PENINGKATAN KESEHATAN INDIVIDU DAN KELUARGA

Resta Betaliani Wirata, S.Kep., Ns., MSN.



A. Pendahuluan / Prolog

Peran keperawatan dalam konteks pelayanan kesehatan tidak hanya mencakup pemberian asuhan klinis secara teknis, tetapi juga berperan strategis dalam peningkatan kualitas hidup individu dan keluarga. Paradigma keperawatan modern menempatkan asuhan keperawatan sebagai bagian integral dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, rehabilitasi, serta pemberdayaan sosial-kultural dalam sistem kesehatan masyarakat (Potter & Perry, 2021). Kontribusi keperawatan dalam meningkatkan kesehatan individu dan keluarga menjadi sangat penting karena keluarga merupakan unit sosial pertama yang memengaruhi perilaku kesehatan, pola asuh, serta dukungan dalam siklus kehidupan seseorang (Alligood, 2018).

Kesehatan individu tidak dapat dipisahkan dari konteks keluarga. Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama yang membentuk pola hidup sehat, memengaruhi kepatuhan terhadap intervensi kesehatan, dan menyediakan dukungan emosional serta praktis dalam perawatan kesehatan (Rolland & Walsh, 2015). Oleh karena itu, intervensi keperawatan harus dirancang tidak hanya untuk kebutuhan klinis pasien tetapi juga untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam mengelola kesehatan anggotanya. Hal ini mencerminkan pergeseran pendekatan keperawatan yang bersifat kuratif semata menuju pendekatan holistik yang integratif, berbasis bukti, dan berorientasi pada pemberdayaan klien dan keluarganya (Whitehead et al., 2016).

Di tingkat praktik, perawat memiliki tanggung jawab dalam melakukan asesmen komprehensif yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan budaya pasien serta keluarganya. Hasil asesmen ini menjadi dasar perencanaan intervensi yang mempertimbangkan determinan kesehatan, faktor risiko lingkungan, serta dinamika keluarga yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan (Stanhope & Lancaster, 2020). Peran keperawatan tidak hanya terbatas pada pemberian edukasi kesehatan, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan perilaku, koordinator layanan, advokat klien, dan agen perubahan dalam komunitas (American Nurses Association, 2015).

Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang peran keperawatan dalam konteks peningkatan kesehatan individu dan keluarga merupakan landasan penting untuk mengembangkan praktik keperawatan yang ilmiah, etis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bab ini akan menguraikan konsep, strategi, dan tantangan implementasi peran keperawatan dalam meningkatkan kesehatan individu dan keluarga berdasarkan bukti ilmiah dan prinsip keperawatan profesional.

B. Konsep Dasar Peran Keperawatan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Secara profesional, peran keperawatan dapat diartikan sebagai seperangkat fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh perawat berdasarkan kompetensi, standar praktik, serta kode etik profesi. *American Nurses Association* (ANA) (2015) menyatakan bahwa praktik keperawatan mencakup perlindungan, promosi, dan optimalisasi kesehatan; pencegahan penyakit dan cedera; serta pengurangan penderitaan melalui diagnosis dan pengobatan respons manusia.

Secara konseptual, keperawatan didasarkan pada pendekatan holistik yang memandang individu sebagai makhluk biopsikososial-spiritual. Teori keperawatan seperti *Self-Care Deficit Theory* (Orem, 2001) dan *Adaptation Model* (Roy, 2009) menekankan pentingnya peran perawat dalam mendukung kemampuan adaptasi dan kemandirian individu dalam mengelola kesehatannya.

Hakikat peran keperawatan bersifat dinamis dan kontekstual. Artinya, pelaksanaan peran perawat dipengaruhi oleh kebutuhan pasien, setting pelayanan (rumah sakit, komunitas, keluarga), serta perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan. Stanhope dan Lancaster (2020) menekankan bahwa dalam konteks kesehatan masyarakat, peran perawat tidak hanya individualistik, tetapi juga populasi-sentris, dengan fokus pada pencegahan dan promosi kesehatan.

2. Landasan Filosofis dan Teoretis Keperawatan

Konsep dasar peran keperawatan tidak terlepas dari teori-teori keperawatan yang memberikan arah dalam praktik profesional.

a. Teori *Self-Care Deficit* (Orem)

Orem (2001) menyatakan bahwa individu memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri (*self-care agency*). Peran perawat muncul ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan perawatan diri akibat keterbatasan fisik, psikologis, atau situasional. Dalam konteks ini, perawat berfungsi sebagai pendukung, pendidik, atau pengganti sementara hingga individu mampu mandiri.

b. Model Adaptasi Roy

Roy (2009) memandang individu sebagai sistem adaptif yang terus berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal. Peran perawat adalah membantu individu beradaptasi terhadap perubahan atau stresor guna mempertahankan integritas dan keseimbangan kesehatan.

c. Pendekatan *Person-Centered Care*

Pendekatan ini menekankan kemitraan terapeutik antara perawat dan pasien. McCormack dan McCance (2017) menjelaskan bahwa praktik berpusat pada pasien mengedepankan penghargaan terhadap nilai, preferensi, serta pengalaman unik individu dalam proses pengambilan keputusan kesehatan.

3. Dimensi Utama Peran Keperawatan

Peran merupakan keadaan dari tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang, sesuai dengan kedudukannya dalam suatu lingkungan. Peran perawat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar profesi keperawatan dan bersifat konstant (Serri, 2021).

Menurut Doheny, peran perawat terdiri dari 8 elemen, yaitu :

a. Care provider (pemberi asuhan keperawatan)

Peran perawat sebagai care provider adalah perawat sebagai pelaku atau pemberi asuhan keperawatan yang dapat memberikan pelayanan keperawatan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada klien dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan yang meliputi: pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana dan tindakan serta evaluasi keperawatan. Dalam hal ini perawat juga harus memperhatikan individu atau klien sebagai makhluk yang holistik dan unik.

b. Counsellor (konselor)

Peran perawat sebagai konselor adalah mengidentifikasi perubahan pola interaksi klien terhadap keadaan sehat - sakitnya. Interaksi ini merupakan dasar dalam merencanakan metode untuk meningkatkan kemampuan adaptasi klien dan juga memberikan konseling atau bimbingan kepada klien, keluarga maupun masyarakat tentang masalah kesehatan sesuai dengan prioritas masalah yang dialaminya. Konseling ini diberikan untuk mengintegrasikan pengalaman klien terhadap kesehatannya dan juga terhadap pemecahan masalah yang difokuskan pada masalah keperawatan untuk mengubah perilaku hidup klien kearah perilaku hidup sehat.

c. Educator (pendidik)

Peran perawat sebagai pendidik klien adalah membantu klien meningkatkan kesehatannya melalui pemberian pengetahuan (edukasi) yang terkait dengan keperawatan dan tindakan medik yang diterima klien, sehingga klien atau keluarga dapat menerima tanggungjawab terhadap hal-hal yang diketahuinya.

Dalam hal ini, perawat juga dapat memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga yang beresiko tinggi terhadap masalah kesehatan.

d. Collaborator (kolaborasi)

Peran perawat sebagai Collaborator adalah perawat bekerja sama dengan keluarga dan tim kesehatan lainnya dalam menentukan rencana ataupun pelaksanaan asuhan keperawatan yang akan diberikan kepada klien untuk memenuhi kebutuhan klien terhadap kesehatannya.

e. Coordinator (koordinator)

Peran perawat sebagai koordinator adalah perawat dalam memberikan perawatan kepada klien dapat memanfaatkan semua sumber-sumber dan potensi yang ada, baik materi maupun kemampuan klien secara terkoordinasi sehingga tidak ada intervensi yang terlewatkan maupun tumpang tindih. Hal-hal yang perlu dilakukan perawat dalam menjalankan perannya sebagai koordinator adalah :

- 1) Memantau atau mengkoordinasi seluruh pelayanan keperawatan.
- 2) Mengatur tenaga keperawatan yang bertugas.
- 3) Mengembangkan sistem pelayanan keperawatan.
- 4) Memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan pelayanan keperawatan pada sarana kesehatan.

f. Change agen (pembaharu)

Peran perawat sebagai pembaharu adalah perawat mengadakan inovasi atau pembaharuan kepada klien terhadap cara berfikir, bersikap dan bertindak untuk meningkatkan keterampilan klien atau keluarga untuk mencapai hidup yang sehat.

g. Consultan (konsultan)

Peran perawat sebagai konsultan adalah perawat sebagai pusat atau sumber informasi yang berkaitan dengan kondisi klien (Serri, 2021).

C. Peran Keperawatan dalam Peningkatan Kesehatan Individu

Menurut World Health Organization (WHO) (1948), kesehatan adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi ini secara implisit memandang individu sebagai entitas multidimensional yang tidak dapat direduksi hanya pada aspek biologis. Dengan demikian, individu dalam konteks kesehatan merupakan makhluk holistik yang berinteraksi dengan lingkungannya secara terus-menerus.

Dalam perspektif keperawatan, Roy (2009) melalui Adaptation Model mendefinisikan individu sebagai sistem adaptif biopsikososial yang secara konstan berinteraksi dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Individu

dipandang memiliki mekanisme koping yang memungkinkan dirinya beradaptasi terhadap stimulus guna mempertahankan integritas dan keseimbangan kesehatan.

Sementara itu, Orem (2001) dalam Self-Care Deficit Theory menjelaskan bahwa individu adalah agen perawatan diri (self-care agent) yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan secara sadar dalam mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Dalam pandangan ini, individu memiliki kapasitas rasional dan tanggung jawab terhadap pengelolaan kesehatannya sendiri.

Alligood (2018) menegaskan bahwa dalam teori-teori keperawatan modern, individu dipahami sebagai makhluk unik yang memiliki kebutuhan, nilai, pengalaman, serta respons yang berbeda terhadap kondisi kesehatan dan penyakit. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan kesehatan harus bersifat individualistik dan berpusat pada klien (person-centered care). Berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa individu dalam perspektif kesehatan adalah suatu kesatuan utuh yang memiliki kemampuan adaptasi, kapasitas perawatan diri, serta dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan dalam menentukan status kesehatannya.

Peran Keperawatan dalam peningkatan kesehatan individu yaitu:

1. Peran Promotif

Dalam aspek promotif, perawat berperan dalam meningkatkan kesadaran dan literasi kesehatan melalui edukasi yang sistematis dan berbasis bukti. Edukasi mencakup pola makan sehat, aktivitas fisik, manajemen stres, serta pencegahan faktor risiko penyakit kronis. Peningkatan literasi kesehatan terbukti berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terapi dan pengambilan keputusan kesehatan yang lebih rasional (Whitehead et al., 2016).

Peran promotif berfokus pada upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan faktor risiko sebelum terjadinya penyakit. Dalam domain ini, perawat bertindak sebagai edukator dan fasilitator perubahan perilaku.

a. Edukasi Kesehatan

Perawat memberikan informasi yang sistematis dan berbasis bukti mengenai pola hidup sehat, nutrisi seimbang, aktivitas fisik, manajemen stres, kesehatan reproduksi, serta pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Edukasi kesehatan bertujuan meningkatkan literasi kesehatan sehingga individu mampu mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatannya (Whitehead et al., 2016).

b. Pemberdayaan dan Advokasi

Perawat mendorong partisipasi aktif klien dalam menjaga kesehatannya serta mendukung kebijakan yang berorientasi pada promosi kesehatan. Peran advokasi ini mencerminkan tanggung jawab etis perawat dalam melindungi

dan mengoptimalkan kesejahteraan pasien (American Nurses Association, 2015).

Upaya promotif sangat relevan dalam menghadapi peningkatan prevalensi penyakit kronis yang berkaitan dengan gaya hidup, seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular.

2. Peran Preventif

Upaya preventif dilakukan melalui deteksi dini faktor risiko, skrining kesehatan, imunisasi, dan konseling perubahan perilaku. Perawat memiliki posisi strategis dalam pencegahan primer, sekunder, dan tersier guna menurunkan angka morbiditas dan mortalitas (Stanhope & Lancaster, 2020). Peran preventif bertujuan mengurangi risiko terjadinya penyakit atau mencegah komplikasi lebih lanjut melalui intervensi dini.

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer dilakukan sebelum timbulnya penyakit, misalnya melalui imunisasi, edukasi kebersihan, dan konseling gaya hidup sehat. Perawat memiliki tanggung jawab dalam mengidentifikasi faktor risiko serta memberikan intervensi yang sesuai untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan (Stanhope & Lancaster, 2020).

b. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder dilakukan melalui deteksi dini dan skrining kesehatan, seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan skrining kanker. Intervensi ini bertujuan mengidentifikasi penyakit pada tahap awal sehingga pengobatan dapat segera dilakukan dan komplikasi dapat diminimalkan.

c. Pencegahan Tersier

Pada tahap ini, perawat berperan dalam mencegah kecacatan atau komplikasi lanjutan melalui pengelolaan penyakit kronis dan pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan (Potter et al., 2021).

3. Peran Kuratif

Dalam konteks kuratif, perawat melaksanakan proses keperawatan secara sistematis: pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Proses ini memastikan bahwa asuhan yang diberikan bersifat individual, terukur, dan sesuai dengan standar praktik profesional (Potter et al., 2021). Peran kuratif berkaitan dengan pemberian asuhan keperawatan kepada individu yang mengalami gangguan kesehatan. Dalam konteks ini, perawat menjalankan proses keperawatan secara sistematis, yaitu:

a. Pengkajian: mengumpulkan data secara komprehensif.

b. Diagnosis Keperawatan: mengidentifikasi respons klien terhadap masalah kesehatan.

- c. Perencanaan: menyusun intervensi berbasis kebutuhan individu.
- d. Implementasi: melaksanakan tindakan keperawatan.
- e. Evaluasi: menilai efektivitas intervensi yang diberikan.

Peran kuratif tidak hanya mencakup tindakan teknis, tetapi juga dukungan emosional dan psikososial kepada pasien dan keluarganya. Hal ini penting untuk mempercepat proses penyembuhan serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan (Potter et al., 2021).

4. Peran Rehabilitatif

Perawat mendukung individu dalam proses pemulihan dan adaptasi pasca-penyakit melalui latihan aktivitas sehari-hari, manajemen nyeri, serta dukungan psikososial. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan mempertahankan fungsi optimal klien. Peran rehabilitatif bertujuan membantu individu mencapai fungsi optimal setelah mengalami penyakit, cedera, atau kondisi kronis.

a. Pemulihan Fungsi Fisik dan Psikososial

Perawat mendukung pasien dalam melakukan latihan aktivitas sehari-hari, terapi mobilisasi, manajemen nyeri, serta adaptasi terhadap perubahan kondisi fisik. Pendekatan ini membantu pasien mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup (Roy, 2009).

b. Dukungan Keluarga dan Lingkungan

Dalam proses rehabilitasi, perawat juga melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung utama. Edukasi dan pelatihan kepada keluarga menjadi bagian penting dalam menjamin keberlanjutan perawatan di rumah.

Peran rehabilitatif sangat penting dalam pengelolaan penyakit kronis, stroke, cedera tulang belakang, serta kondisi pasca-operasi.

D. Peran Keperawatan dalam Konteks Keluarga

Dalam konteks kesehatan, keluarga dipandang sebagai unit sosial dasar yang memiliki peran signifikan dalam menentukan status kesehatan individu. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai sistem pendukung emosional, tetapi juga sebagai lingkungan utama yang membentuk perilaku kesehatan, pola hidup, serta respons terhadap penyakit.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan keluarga sebagai anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui ikatan darah, perkawinan, atau adopsi, yang hidup bersama dan berinteraksi dalam peran sosial masing-masing. Dalam konteks kesehatan masyarakat, keluarga dipandang sebagai unit utama dalam promosi kesehatan dan pencegahan penyakit karena memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku dan lingkungan hidup anggotanya (WHO, 2013).

Friedman, Bowden, dan Jones (2003) dalam perspektif keperawatan keluarga mendefinisikan keluarga sebagai dua orang atau lebih yang memiliki komitmen emosional, berbagi nilai, dan saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial. Dalam bidang kesehatan, keluarga dipandang sebagai sistem yang saling memengaruhi, di mana perubahan status kesehatan satu anggota akan berdampak pada keseluruhan sistem keluarga.

Stanhope dan Lancaster (2020) mendefinisikan keluarga sebagai sekelompok individu yang terikat melalui hubungan biologis, legal, atau emosional, yang berfungsi sebagai unit perawatan dalam praktik keperawatan komunitas. Mereka menekankan bahwa keluarga merupakan klien dalam praktik kesehatan masyarakat, karena intervensi kesehatan sering kali lebih efektif bila dilakukan pada tingkat keluarga dibandingkan individu semata.

Kaakinen, Coehlo, Steele, Tabacco, dan Hanson (2018) menjelaskan bahwa keluarga adalah sistem sosial yang dinamis dan terbuka, yang berinteraksi dengan lingkungan dan memiliki struktur, fungsi, serta peran yang memengaruhi kesehatan anggotanya. Dalam teori Family Systems Nursing, keluarga dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perawatan kesehatan.

Keluarga merupakan unit sosial utama yang memengaruhi perilaku kesehatan individu. Oleh karena itu, asuhan keperawatan tidak dapat dipisahkan dari konteks keluarga.

1. Asesmen Keluarga

Perawat melakukan pengkajian terhadap struktur, fungsi, dan dinamika keluarga untuk mengidentifikasi faktor risiko serta sumber daya internal keluarga (Rolland & Walsh, 2015).

a. Konsep dan Tujuan Asesmen Keluarga

Asesmen keluarga merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi struktur, fungsi, peran, nilai, serta sumber daya keluarga yang berkaitan dengan status kesehatan anggotanya. Tujuan utama asesmen adalah memperoleh gambaran komprehensif mengenai kebutuhan kesehatan keluarga serta faktor risiko dan protektif yang memengaruhi kesejahteraan mereka (Friedman et al., 2003).

Menurut Kaakinen et al. (2018), asesmen keluarga meliputi tiga komponen utama:

- 1) Struktur keluarga, mencakup komposisi, pola hubungan, dan sistem pendukung.
- 2) Fungsi keluarga, termasuk fungsi afektif, sosialisasi, reproduksi, ekonomi, dan perawatan kesehatan.

3) Proses keluarga, yaitu pola komunikasi, pengambilan keputusan, serta mekanisme coping terhadap stresor.

Dalam konteks Indonesia, asesmen keluarga dalam praktik pelayanan primer mengacu pada indikator keluarga sehat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI (2016), seperti kepesertaan JKN, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengendalian penyakit kronis.

b. Pendekatan dan Instrumen Asesmen

Pendekatan asesmen keluarga dapat menggunakan berbagai model, seperti Family Systems Theory dan Calgary Family Assessment Model (CFAM), yang menekankan hubungan timbal balik antaranggota keluarga (Wright & Leahey, 2013). Instrumen seperti genogram dan ecomap juga digunakan untuk memetakan struktur dan hubungan sosial keluarga.

Asesmen yang komprehensif memungkinkan perawat merancang intervensi yang kontekstual, efektif, dan berkelanjutan.

2. Pemberdayaan dan Edukasi Keluarga

Pemberdayaan keluarga dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam merawat anggota keluarga yang sakit, serta dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Pendekatan ini memperkuat peran keluarga sebagai sistem pendukung utama.

a. Konsep Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan keluarga merupakan proses meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan, serta melakukan tindakan mandiri untuk mempertahankan kesehatan anggotanya. Konsep ini sejalan dengan pendekatan promosi kesehatan yang menekankan peningkatan kontrol individu dan keluarga terhadap determinan kesehatan (World Health Organization, 1986).

Dalam praktik keperawatan, pemberdayaan dilakukan melalui kemitraan terapeutik antara perawat dan keluarga. Perawat berperan sebagai fasilitator yang membantu keluarga mengidentifikasi potensi internal serta memanfaatkan sumber daya eksternal secara optimal (Kaakinen et al., 2018).

b. Edukasi Kesehatan Keluarga

Edukasi keluarga bertujuan meningkatkan literasi kesehatan sehingga keluarga mampu:

- 1) Mencegah penyakit,
- 2) Mengelola kondisi kronis,
- 3) Memberikan perawatan dasar di rumah,
- 4) Mengambil keputusan kesehatan secara tepat.

Whitehead et al. (2016) menegaskan bahwa edukasi kesehatan yang efektif harus mempertimbangkan tingkat pendidikan, budaya, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Di Indonesia, edukasi keluarga menjadi bagian penting dalam kegiatan kunjungan rumah dan pembinaan keluarga sehat di layanan primer (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Edukasi yang berkelanjutan terbukti meningkatkan kepatuhan terapi, menurunkan angka kekambuhan, serta memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga.

3. Kolaborasi dan Koordinasi Layanan

Perawat bertindak sebagai koordinator layanan kesehatan dengan melibatkan berbagai tenaga profesional lain guna memastikan kontinuitas pelayanan yang komprehensi

a. Konsep Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi interprofesional merupakan kerja sama antara berbagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang komprehensif dan terintegrasi. Perawat memiliki peran sentral sebagai koordinator pelayanan karena keterlibatannya yang kontinu dalam proses perawatan pasien (American Nurses Association, 2015).

Kolaborasi melibatkan dokter, ahli gizi, fisioterapis, pekerja sosial, serta tenaga kesehatan masyarakat untuk memastikan kesinambungan pelayanan dari fasilitas kesehatan ke rumah dan komunitas (Stanhope & Lancaster, 2020).

b. Koordinasi dan Continuity of Care

Koordinasi layanan mencakup pengaturan rujukan, tindak lanjut pasca perawatan, serta pemantauan kondisi pasien di rumah. Continuity of care menjadi aspek penting dalam mencegah fragmentasi pelayanan dan meningkatkan efisiensi sistem kesehatan (World Health Organization, 2016).

Di Indonesia, sistem rujukan berjenjang dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuntut perawat untuk berperan aktif dalam koordinasi pelayanan primer dan lanjutan agar pelayanan tetap efektif dan berkesinambungan (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

E. Simpulan

Peran keperawatan dalam konteks peningkatan kesehatan individu dan keluarga merupakan suatu pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Perawat berkontribusi tidak hanya dalam perawatan klinis, tetapi juga dalam pemberdayaan individu dan keluarga melalui edukasi, advokasi, koordinasi layanan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemahaman yang komprehensif terhadap peran ini

menjadi fundamental dalam mengembangkan praktik keperawatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

F. Referensi

- Alligood, M. R. (2018). *Nursing Theorists and Their Work* (9th ed.). Elsevier.
- American Nurses Association. (2015). *Code of Ethics for Nurses with Interpretive Statements*. ANA.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2003). *Family nursing: Research, theory, and practice* (5th ed.). Prentice Hall.
- Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., Tabacco, A., & Hanson, S. M. H. (2018). *Family health care nursing: Theory, practice, and research* (6th ed.). F.A. Davis.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Pedoman Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)*. Kemenkes RI.
- McCormack, B., & McCance, T. (2017). *Person-centred practice in nursing and health care: Theory and practice* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Orem, D. E. (2001). *Nursing: Concepts of practice* (6th ed.). Mosby.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Rolland, J. S., & Walsh, F. (Eds.). (2015). *Handbook of Family Resilience*. Springer.
- Roy, C. (2009). *The Roy adaptation model* (3rd ed.). Pearson.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in the Community* (10th ed.). Elsevier.
- Whitehead, D., Doran, E., & Gilbert, M. (2016). *Community and Public Health Nursing* (5th ed.). Elsevier.
- World Health Organization. (2013). *Health 2020: A European policy framework supporting action across government and society for health and well-being*. WHO Regional Office for Europe.
- Wright, L. M., & Leahey, M. (2013). *Nurses and families: A guide to family assessment and intervention* (6th ed.). F.A. Davis.

G. Glosarium

set keluarga (sumber daya internal/eksternal): Kekuatan, dukungan, dan sumber daya yang dimiliki keluarga untuk mengelola masalah kesehatan.

Badan biopsikososial-spiritual: Konsep holistik yang melihat manusia sebagai kesatuan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.

Care provider: Peran perawat sebagai pemberi asuhan langsung/tidak langsung melalui proses keperawatan (pengkajian–evaluasi).

Diagnosis keperawatan: Identifikasi respons klien terhadap masalah kesehatan yang menjadi dasar intervensi keperawatan.

Ecomap: Alat pemetaan hubungan keluarga dengan lingkungan sosial/sumber dukungan di luar keluarga (tetangga, tempat kerja, komunitas).

Fungsi keluarga: Peran keluarga dalam aspek afektif, sosialisasi, reproduksi, ekonomi, dan perawatan kesehatan.

Genogram: Diagram yang memetakan struktur keluarga, hubungan antar anggota, dan pola kesehatan/penyakit lintas generasi.

Holistik: Pendekatan yang melihat klien sebagai individu utuh (fisik, mental, sosial, spiritual) dan mempertimbangkan konteks kehidupan.

Imunisasi: Intervensi pencegahan primer untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit tertentu.

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional): Sistem asuransi kesehatan nasional di Indonesia yang menerapkan rujukan berjenjang dan memengaruhi koordinasi layanan.



CHAPTER 5

PERAN GIZI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

AASP Chandradewi, SKM., M.Kes.



A. Pendahuluan / Prolog

Masalah kesehatan masyarakat saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, terutama yang berkaitan dengan status gizi penduduk. Secara global, dunia masih menghadapi beban malnutrisi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekurangan gizi, defisiensi mikronutrien, hingga kelebihan gizi dan obesitas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa ratusan juta anak di dunia masih mengalami stunting dan wasting, sementara prevalensi overweight dan obesitas terus meningkat pada semua kelompok umur. Kondisi ini menunjukkan terjadinya beban gizi ganda, di mana masalah gizi kurang dan gizi lebih terjadi secara bersamaan dalam satu populasi. (*Kementerian Kesehatan RI, 2020; WHO, 2021*).

Di Indonesia, permasalahan tersebut juga tampak nyata. Data survei nasional menunjukkan bahwa stunting pada balita masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan meskipun trennya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Selain stunting, masalah wasting, underweight, dan anemia masih banyak ditemukan, terutama pada kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan remaja putri. Di sisi lain, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi obesitas dan penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes melitus, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. (WHO, 2021)

Kondisi ini menempatkan Indonesia pada situasi transisi gizi dan epidemiologi, di mana masalah kekurangan gizi kronis masih berlangsung bersamaan dengan peningkatan penyakit degeneratif. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Status gizi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas kesehatan masyarakat. Gizi yang baik berperan penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan dan perkembangan optimal, kapasitas belajar, serta produktivitas kerja. Individu dengan status gizi baik cenderung memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit infeksi dan penyakit tidak menular, serta kualitas hidup yang lebih baik. Sebaliknya, status gizi yang buruk, baik dalam bentuk kekurangan

maupun kelebihan, meningkatkan kerentanan terhadap berbagai masalah kesehatan. Kekurangan gizi pada anak, khususnya stunting, berhubungan dengan gangguan perkembangan kognitif, prestasi belajar yang rendah, dan risiko penyakit kronis di usia dewasa. Defisiensi zat gizi mikro seperti zat besi berkontribusi terhadap anemia yang dapat menurunkan kapasitas kerja dan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Sementara itu, gizi lebih dan obesitas berkaitan erat dengan meningkatnya kejadian PTM yang membutuhkan biaya pengobatan jangka panjang.

Dengan demikian, status gizi dapat dipandang sebagai indikator penting kualitas kesehatan masyarakat dan sebagai faktor kunci yang memengaruhi derajat kesehatan populasi secara keseluruhan. (*Mahan and Raymond, 2020; WCRF, 2018*).

Intervensi gizi tidak hanya merupakan upaya kuratif atau preventif jangka pendek, tetapi juga merupakan investasi kesehatan jangka panjang. Berbagai kajian menunjukkan bahwa perbaikan status gizi, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), memberikan dampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak yang tumbuh dengan status gizi optimal memiliki peluang lebih besar untuk mencapai potensi fisik dan intelektualnya secara maksimal.

Dari perspektif ekonomi kesehatan, intervensi gizi terbukti cost-effective karena mampu menurunkan beban penyakit, mengurangi biaya pelayanan kesehatan, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan kesehatan yang berkelanjutan perlu menempatkan gizi sebagai prioritas utama, melalui pendekatan promotif dan preventif yang terintegrasi dengan sektor lain seperti pendidikan, pangan, sanitasi, dan perlindungan sosial.

Pendekatan berbasis masyarakat, termasuk pemanfaatan potensi lokal dan praktik positif yang telah ada, menjadi semakin relevan untuk memastikan intervensi gizi dapat diterima, berkelanjutan, dan berdampak nyata.

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran gizi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Secara khusus, pembahasan dalam bab ini mencakup:

1. Konsep dasar gizi dalam kerangka kesehatan masyarakat.
2. Gambaran masalah gizi global dan nasional serta implikasinya terhadap kualitas kesehatan.
3. Hubungan antara status gizi, stunting, dan indikator komposit seperti Composite Anthropometric Failure (CIAF).
4. Urgensi intervensi gizi sebagai strategi pembangunan kesehatan jangka panjang.
5. Implikasi kebijakan dan pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung perbaikan status gizi masyarakat.

B. Konsep Dasar Gizi dalam Kerangka Kesehatan Masyarakat

1. Pengertian Gizi dalam Kesehatan Masyarakat

Gizi dalam konteks kesehatan masyarakat didefinisikan sebagai ilmu dan upaya yang berkaitan dengan ketersediaan, konsumsi, penyerapan, dan pemanfaatan zat gizi oleh tubuh dalam suatu populasi, serta dampaknya terhadap status kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan klinis yang berfokus pada individu, gizi kesehatan masyarakat menitikberatkan pada kelompok penduduk, determinan sosial, serta faktor lingkungan dan kebijakan yang memengaruhi status gizi secara luas.

Pendekatan ini memandang masalah gizi sebagai hasil interaksi antara faktor biologis, sosial-ekonomi, budaya, lingkungan, dan sistem kesehatan. Oleh karena itu, penanggulangan masalah gizi tidak dapat dilakukan hanya melalui intervensi medis, tetapi memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai sektor.

2. Gizi sebagai Determinan Kesehatan

Dalam kerangka determinan kesehatan, gizi merupakan faktor kunci yang berkontribusi langsung terhadap derajat kesehatan masyarakat. Model determinan kesehatan menunjukkan bahwa status gizi dipengaruhi oleh:

- a. Faktor langsung, seperti asupan makanan dan status kesehatan (infeksi, penyakit kronis).
- b. Faktor tidak langsung, meliputi ketahanan pangan rumah tangga, pola asuh dan perilaku konsumsi, sanitasi dan lingkungan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan.
- c. Faktor dasar, yaitu kondisi sosial-ekonomi, pendidikan, budaya, dan kebijakan publik.

Ketidakseimbangan pada salah satu faktor tersebut dapat berdampak pada terjadinya berbagai bentuk malnutrisi, baik gizi kurang, defisiensi mikronutrien, maupun gizi lebih dan obesitas.

3. Spektrum Masalah Gizi dalam Kesehatan Masyarakat

Masalah gizi dalam kesehatan masyarakat mencakup spektrum yang luas, antara lain:

- a. Gizi kurang dan gizi buruk, yang sering ditemukan pada kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan masyarakat miskin.
- b. Defisiensi zat gizi mikro, seperti anemia defisiensi besi, kekurangan vitamin A, dan defisiensi yodium, yang berdampak pada pertumbuhan, perkembangan kognitif, dan produktivitas.
- c. Gizi lebih dan obesitas, yang berkaitan dengan perubahan pola konsumsi, urbanisasi, dan gaya hidup sedentari.

d. Beban gizi ganda, di mana gizi kurang dan gizi lebih terjadi secara bersamaan dalam satu populasi, bahkan dalam satu rumah tangga.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah gizi tidak bersifat tunggal, melainkan kompleks dan dinamis, sehingga memerlukan pendekatan yang adaptif dan berbasis bukti.

4. Gizi dalam Pendekatan Siklus Kehidupan (Life Course Approach)

Pendekatan siklus kehidupan menempatkan gizi sebagai faktor yang berperan sepanjang rentang kehidupan manusia, mulai dari periode pra-konsepsi, kehamilan, bayi dan balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Kekurangan gizi pada fase awal kehidupan, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang bersifat permanen, termasuk stunting, gangguan perkembangan kognitif, dan peningkatan risiko penyakit tidak menular di usia dewasa. Sebaliknya, perbaikan gizi pada setiap tahap kehidupan memberikan efek protektif terhadap kesehatan dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

5. Indikator Status Gizi dalam Kesehatan Masyarakat

Untuk menilai status gizi pada tingkat populasi, digunakan berbagai indikator, antara lain:

- a. Indikator antropometri: stunting, wasting, underweight, overweight, dan obesitas.
- b. Indikator klinis dan biokimia: anemia, defisiensi vitamin dan mineral.
- c. Indikator konsumsi pangan: kecukupan energi dan zat gizi, keragaman pangan.

Selain indikator tunggal, pendekatan Composite Anthropometric Failure (CIAF) digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kegagalan pertumbuhan anak, dengan menggabungkan beberapa indikator antropometri sekaligus. Pendekatan ini sangat relevan dalam analisis kesehatan masyarakat karena mampu mengidentifikasi beban gizi secara lebih utuh.

6. Peran Gizi dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Dalam kerangka kesehatan masyarakat, gizi berperan sebagai:

- a. Upaya promotif, melalui edukasi gizi dan pembentukan perilaku makan sehat.
- b. Upaya preventif, dengan mencegah terjadinya kekurangan gizi, anemia, obesitas, dan PTM.
- c. Upaya kuratif dan rehabilitatif, khususnya pada kelompok dengan masalah gizi spesifik.

Intervensi gizi yang terintegrasi dan berkelanjutan berkontribusi pada penurunan angka kesakitan dan kematian, peningkatan produktivitas, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia.

7. Gambaran Masalah Gizi Global dan Nasional serta Implikasinya terhadap Kualitas Kesehatan

Masalah gizi masih menjadi tantangan global yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan ketahanan pembangunan. Laporan FAO et al. (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 735 juta penduduk dunia masih mengalami kekurangan pangan, dengan prevalensi tertinggi pada ibu hamil dan anak balita. Kekurangan asupan energi dan zat gizi esensial berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit infeksi, keterlambatan tumbuh kembang, serta kematian dini (*Black et al., 2013; WHO, 2020*).

Di Indonesia, permasalahan gizi kronis tercermin dari tingginya prevalensi stunting yang masih mencapai 21,6% pada tahun 2022 (*Kemendes RI, 2022*). Kondisi ini menunjukkan bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang bersifat permanen. Stunting tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga pada fungsi kognitif, kapasitas belajar, dan produktivitas ekonomi saat dewasa (*Victora et al., 2010; Shekar et al., 2017*).

Masalah gizi juga memperlemah kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan kerentanan terhadap penyakit menular dan tidak menular. Anak yang kurang gizi memiliki daya tahan tubuh lebih rendah dan risiko lebih tinggi terhadap tuberkulosis, diare, dan infeksi saluran pernapasan (*Black et al., 2013; Mosley and Chen, 1984*).

a. Masalah Gizi Global

Secara global, kekurangan gizi pada ibu dan anak masih menjadi penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian, terutama di negara berpendapatan rendah dan menengah. Stunting pada anak balita masih menjadi perhatian serius karena berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan produktivitas di usia dewasa. Selain stunting, wasting dan underweight juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kematian anak, khususnya akibat penyakit infeksi. (Unicef, 2025)

Di sisi lain, dunia juga menghadapi peningkatan prevalensi gizi lebih dan obesitas yang berkontribusi terhadap meningkatnya penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, penyakit kardiovaskular, dan beberapa jenis kanker. Perubahan pola konsumsi pangan, urbanisasi, serta gaya hidup sedentari menjadi faktor utama terjadinya transisi gizi global. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah gizi tidak lagi bersifat tunggal, melainkan kompleks dan multidimensional.

b. Masalah Gizi Nasional

Di Indonesia, permasalahan gizi mencerminkan kondisi global tersebut. Indonesia masih menghadapi masalah gizi kronis seperti stunting dan anemia, terutama pada kelompok ibu hamil dan balita, sekaligus peningkatan prevalensi gizi lebih dan obesitas pada kelompok usia dewasa. Ketimpangan sosial ekonomi, akses terhadap pangan bergizi, serta perbedaan kondisi geografis turut memperlebar disparitas status gizi antarwilayah.

Penilaian status gizi di tingkat nasional selama ini banyak menggunakan indikator antropometri tunggal, seperti tinggi badan menurut umur untuk stunting. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya menggambarkan beban masalah gizi yang sebenarnya. Pendekatan Composite Anthropometric Failure (CIAF) menunjukkan bahwa proporsi anak yang mengalami kegagalan pertumbuhan sering kali lebih tinggi dibandingkan hasil penilaian menggunakan satu indikator saja. Hal ini mengindikasikan adanya kelompok anak yang luput dari intervensi apabila perencanaan program hanya berfokus pada satu indikator gizi.

c. Implikasi Masalah Gizi terhadap Kualitas Kesehatan

Masalah gizi memiliki implikasi luas terhadap kualitas kesehatan individu dan masyarakat. Kekurangan gizi pada periode awal kehidupan berdampak pada gangguan pertumbuhan fisik, penurunan fungsi kognitif, serta peningkatan risiko penyakit infeksi. Dampak jangka panjangnya mencakup penurunan produktivitas, peningkatan risiko penyakit tidak menular di usia dewasa, serta menurunnya kualitas sumber daya manusia. (*Kementerian Kesehatan RI, 2020; UNICEF, 2022*).

Pendekatan CIAF memperkuat pemahaman bahwa masalah gizi sering kali bersifat tumpang tindih dan saling berkaitan. Anak yang mengalami lebih dari satu kegagalan antropometri memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan anak dengan satu bentuk kegagalan gizi. Oleh karena itu, perencanaan dan implementasi program gizi perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif agar intervensi yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas kesehatan secara menyeluruh. (Chandradewi, A.A.S.P., 2025)

d. Implikasi terhadap Kebijakan dan Pembelajaran

Intervensi gizi bukan sekadar tindakan kesehatan, melainkan investasi pembangunan manusia. World Bank (2020) menunjukkan bahwa setiap 1 dolar AS yang diinvestasikan pada gizi anak dapat menghasilkan hingga 16 dolar dalam bentuk produktivitas ekonomi jangka panjang.

Intervensi gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) terbukti paling efektif dalam mencegah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*Victora et al., 2010; WHO, 2014*). Tanpa intervensi dini, kerusakan akibat kekurangan gizi bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi pada usia dewasa.

Pendekatan gizi spesifik (suplementasi, PMT, fortifikasi) harus dikombinasikan dengan intervensi gizi sensitif seperti ketahanan pangan, sanitasi, dan pendidikan ibu (*Ruel and Alderman, 2013; FAO et al., 2023*). Inilah dasar ilmiah pendekatan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.

e. Implikasi Kebijakan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian (CIAF & Stunting)

Kebijakan nasional Indonesia telah menempatkan stunting sebagai prioritas pembangunan melalui Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018–2024 (*Kemenkes RI, 2021*). Namun, sebagian besar program masih menggunakan indikator tunggal (TB/U), sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas masalah gizi.

Penggunaan CIAF sebagai indikator perencanaan memungkinkan pemerintah mengidentifikasi anak yang mengalami multiple burden of malnutrition dan menargetkan intervensi secara lebih tepat (*Nandy et al., 2005; Alemu et al., 2023, Chandradewi, 2025*).

Bagi mahasiswa gizi dan kesehatan masyarakat, pemahaman CIAF memperluas perspektif analisis masalah gizi dari sekadar prevalensi stunting menuju pendekatan risiko dan ketahanan pangan berbasis rumah tangga (*Bose and Mandal, 2010; Ruel and Alderman, 2013*).

Dengan demikian, integrasi hasil penelitian CIAF ke dalam kebijakan gizi dapat mempercepat pencapaian target SDGs, RPJMN, dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia (*World Bank, 2020; Kemenkes RI, 2022*).

C. Hubungan antara Status Gizi, Stunting, dan CIAF

Status gizi anak secara tradisional diukur melalui indikator tunggal seperti berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Namun, pendekatan ini sering gagal menangkap kondisi anak yang mengalami lebih dari satu bentuk kegagalan pertumbuhan (*Nandy et al., 2005*).

Konsep Composite Anthropometric Failure (CIAF) dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan menggabungkan seluruh bentuk malnutrisi (stunting, wasting, dan underweight) dalam satu indikator komposit (*Bose and Mandal, 2010; Nandy et al., 2005*). CIAF memberikan gambaran yang lebih realistis tentang beban gizi buruk dalam suatu populasi.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa prevalensi CIAF selalu lebih tinggi dibandingkan stunting atau wasting tunggal, sehingga lebih sensitif dalam mengidentifikasi anak berisiko (*Alemu et al., 2023*). Hal ini sangat relevan bagi penelitian Ibu tentang **Positive Deviance dan CIAF di daerah lokus stunting**, karena CIAF mampu mengungkap kelompok anak yang sering luput dari intervensi program. Stunting merupakan manifestasi dari kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, sedangkan CIAF menunjukkan beban total kegagalan pertumbuhan yang mempengaruhi kualitas generasi mendatang (*Victora et al., 2010; Black et al., 2013*).

1. Implikasi Masalah Gizi terhadap Kualitas Kesehatan

Masalah gizi memiliki implikasi luas terhadap kualitas kesehatan individu dan masyarakat. Kekurangan gizi pada periode awal kehidupan berdampak pada gangguan pertumbuhan fisik, penurunan fungsi kognitif, serta peningkatan risiko penyakit infeksi. Dampak jangka panjangnya mencakup penurunan produktivitas, peningkatan risiko penyakit tidak menular di usia dewasa, serta menurunnya kualitas sumber daya manusia. (*Kementerian Kesehatan RI, 2020; UNICEF, 2022*).

Pendekatan CIAF memperkuat pemahaman bahwa masalah gizi sering kali bersifat tumpang tindih dan saling berkaitan. Anak yang mengalami lebih dari satu kegagalan antropometri memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan anak dengan satu bentuk kegagalan gizi. Oleh karena itu, perencanaan dan implementasi program gizi perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif agar intervensi yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas kesehatan secara menyeluruh. (Chandradewi, A.A.S.P., 2025)

2. Implikasi terhadap Kebijakan dan Pembelajaran

Bagi pengambil kebijakan, gambaran masalah gizi global dan nasional menunjukkan perlunya pendekatan terintegrasi yang menggabungkan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Penggunaan indikator komprehensif seperti CIAF dapat meningkatkan akurasi pemetaan masalah gizi dan efektivitas program penanggulangan stunting. Bagi mahasiswa, pemahaman mengenai kompleksitas masalah gizi ini menjadi dasar penting dalam analisis situasi, perencanaan program, serta evaluasi intervensi gizi kesehatan masyarakat.

D. Hubungan antara Status Gizi, Stunting, dan Indikator Komposit seperti Composite Anthropometric Failure (CIAF)

Status gizi merupakan indikator penting dalam menilai kondisi kesehatan individu dan masyarakat. Dalam konteks kesehatan masyarakat, status gizi anak mencerminkan hasil interaksi kompleks antara asupan pangan, penyakit infeksi, pola asuh, lingkungan, serta faktor sosial ekonomi. Penilaian status gizi yang akurat

menjadi dasar penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program gizi, khususnya dalam upaya pencegahan stunting. (Chandradewi, A.A.S.P., 2025)

1. Status Gizi sebagai Cerminan Kesehatan Anak

Status gizi anak umumnya diukur melalui indikator antropometri yang menggambarkan pertumbuhan fisik anak dibandingkan dengan standar pertumbuhan yang telah ditetapkan. Indikator yang lazim digunakan meliputi berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Masing-masing indikator memiliki makna yang berbeda dan mencerminkan kondisi gizi yang spesifik.

TB/U digunakan untuk mengidentifikasi stunting yang mencerminkan masalah gizi kronis, sedangkan BB/TB menggambarkan wasting yang berkaitan dengan masalah gizi akut. BB/U merupakan indikator gabungan yang dapat mencerminkan kondisi gizi kronis maupun akut. Dengan demikian, status gizi anak tidak dapat dipahami secara utuh apabila hanya dilihat dari satu indikator antropometri.

2. Stunting sebagai Manifestasi Masalah Gizi Kronis

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya dan berisiko mengalami gangguan perkembangan kognitif, penurunan kapasitas belajar, serta peningkatan risiko penyakit tidak menular di masa dewasa.

Meskipun stunting menjadi indikator utama dalam kebijakan nasional dan global, fokus yang berlebihan pada satu indikator ini berpotensi mengabaikan bentuk kegagalan gizi lainnya. Anak yang tidak tergolong stunting dapat saja mengalami wasting atau underweight yang juga berdampak signifikan terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup.

3. Keterbatasan Indikator Tunggal dalam Penilaian Status Gizi

Penggunaan indikator tunggal dalam penilaian status gizi memiliki keterbatasan dalam menggambarkan beban masalah gizi secara menyeluruh. Indikator tunggal cenderung mengklasifikasikan anak hanya berdasarkan satu dimensi pertumbuhan, sehingga tidak mampu mengidentifikasi anak dengan kegagalan gizi multipel. Akibatnya, sebagian anak berisiko tinggi dapat luput dari intervensi gizi yang seharusnya mereka terima. Dalam konteks perencanaan program dan kebijakan, keterbatasan ini dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penentuan sasaran, alokasi sumber daya, dan evaluasi dampak intervensi gizi.

4. Composite Anthropometric Failure (CIAF) sebagai Indikator Komprehensif

Composite Anthropometric Failure (CIAF) merupakan indikator komposit yang mengklasifikasikan anak berdasarkan kombinasi kegagalan antropometri, meliputi stunting, wasting, dan underweight. CIAF mengelompokkan anak ke dalam beberapa kategori, mulai dari anak tanpa kegagalan antropometri hingga anak dengan lebih dari satu bentuk kegagalan pertumbuhan.

Pendekatan CIAF memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai beban masalah gizi pada populasi anak. Anak yang tergolong dalam kategori CIAF memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan anak yang hanya mengalami satu jenis kegagalan gizi. Oleh karena itu, CIAF dianggap lebih sensitif dalam mengidentifikasi kelompok anak yang paling membutuhkan intervensi. (Chandradewi, A.A.S.P., 2025)

5. Hubungan Status Gizi, Stunting, dan CIAF

Status gizi, stunting, dan CIAF memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam analisis masalah gizi. Status gizi merupakan konsep umum yang mencerminkan kondisi pertumbuhan dan kesehatan anak. Stunting merupakan salah satu bentuk spesifik dari masalah gizi kronis, sedangkan CIAF berfungsi sebagai indikator komposit yang mengintegrasikan berbagai bentuk kegagalan gizi. Dengan menggunakan CIAF, penilaian status gizi menjadi lebih holistik karena mampu menangkap anak yang mengalami satu atau lebih kegagalan pertumbuhan. Pendekatan ini memperkaya analisis stunting dengan mempertimbangkan dimensi kegagalan gizi lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas kesehatan anak.

6. Implikasi bagi Pendidikan dan Kebijakan Gizi

Bagi mahasiswa gizi dan kesehatan masyarakat, pemahaman hubungan antara status gizi, stunting, dan CIAF penting untuk meningkatkan kemampuan analisis situasi dan interpretasi data gizi. CIAF dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian dan evaluasi program gizi.

Bagi pengambil kebijakan, penggunaan indikator komposit seperti CIAF dapat meningkatkan akurasi pemetaan masalah gizi dan efektivitas intervensi penanggulangan stunting. Pendekatan ini mendukung perencanaan program yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

E. Urgensi Intervensi Gizi sebagai Strategi Pembangunan Kesehatan Jangka Panjang

Intervensi gizi merupakan salah satu strategi paling efektif dan berkelanjutan dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Berbagai bukti ilmiah menunjukkan bahwa perbaikan status gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan individu dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, gizi harus dipandang sebagai investasi strategis dalam pembangunan kesehatan dan sumber daya manusia.

1. Intervensi Gizi sebagai Investasi Kesehatan

Intervensi gizi, khususnya pada periode awal kehidupan, terbukti mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian, meningkatkan kapasitas belajar, serta memperbaiki produktivitas di usia dewasa. Anak dengan status gizi baik memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun kognitif. Dampak jangka panjang dari intervensi gizi yang efektif meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan beban pembiayaan kesehatan. (PMC, 2013). Bagi mahasiswa, pemahaman ini penting untuk melihat gizi tidak hanya sebagai upaya kuratif, tetapi sebagai strategi promotif dan preventif yang memberikan manfaat lintas generasi.

2. Periode Kritis Intervensi Gizi dan Pendekatan Siklus Kehidupan

Urgensi intervensi gizi semakin kuat ketika dikaitkan dengan pendekatan siklus kehidupan. Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan fase kritis yang menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi pada periode ini dapat menyebabkan dampak permanen yang sulit diperbaiki di kemudian hari. Intervensi gizi yang dilakukan sejak masa prakonsepsi, kehamilan, hingga usia balita berperan penting dalam mencegah stunting dan kegagalan pertumbuhan lainnya. Pendekatan CIAF menunjukkan bahwa kegagalan gizi sering kali bersifat multipel, sehingga intervensi gizi harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan.

3. Intervensi Gizi dan Pencegahan Beban Ganda Masalah Kesehatan

Indonesia dan banyak negara lain menghadapi beban ganda masalah gizi, yaitu kekurangan gizi dan gizi lebih yang terjadi secara bersamaan. Intervensi gizi yang tepat tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kekurangan gizi, tetapi juga mencegah meningkatnya risiko gizi lebih dan penyakit tidak menular. Pendekatan gizi seimbang, promosi pola makan sehat, dan edukasi gizi masyarakat merupakan strategi penting dalam mencegah transisi gizi yang berdampak negatif. Dengan demikian, intervensi gizi berkontribusi terhadap pencegahan penyakit tidak menular dan peningkatan kualitas hidup dalam jangka panjang.

4. Implikasi Ekonomi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Masalah gizi berdampak langsung terhadap produktivitas dan daya saing bangsa. Anak yang mengalami stunting dan kegagalan gizi lainnya berisiko memiliki tingkat pendidikan dan produktivitas yang lebih rendah di masa dewasa. Dalam skala nasional, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Intervensi gizi yang efektif merupakan strategi cost-effective dalam pembangunan kesehatan. Investasi pada program gizi memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengurangan biaya pelayanan kesehatan akibat penyakit yang dapat dicegah. (World Bank, 2024)

5. Urgensi Pendekatan Berbasis Bukti dalam Kebijakan Gizi

Urgensi intervensi gizi juga menuntut penggunaan pendekatan berbasis bukti dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Penggunaan indikator komprehensif seperti CIAF memungkinkan identifikasi kelompok berisiko tinggi secara lebih akurat, sehingga intervensi gizi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Hasil penelitian CIAF dan stunting menunjukkan bahwa intervensi gizi yang hanya berfokus pada satu indikator berpotensi kurang efektif. Oleh karena itu, kebijakan gizi perlu mengintegrasikan berbagai indikator dan pendekatan berbasis masyarakat, seperti Positive Deviance, untuk mencapai dampak jangka panjang yang optimal.

F. Implikasi Kebijakan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Mendukung Perbaikan Status Gizi Masyarakat

Hasil penelitian gizi memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan dan program perbaikan status gizi masyarakat. Kebijakan gizi yang efektif harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hasil penelitian mengenai stunting, indikator komposit seperti Composite Anthropometric Failure (CIAF), serta pendekatan berbasis masyarakat menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan kebijakan. (Chandradewi, A.A.S.P., 2025)

1. Penelitian sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Gizi

Penelitian gizi berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi besarnya masalah, faktor determinan, serta kelompok masyarakat yang paling berisiko mengalami masalah gizi. Penggunaan indikator yang komprehensif, seperti CIAF, memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai beban masalah gizi dibandingkan indikator tunggal. Dengan demikian, kebijakan yang disusun berdasarkan hasil penelitian mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

2. Implikasi Kebijakan dari Pendekatan CIAF

Pendekatan CIAF memiliki implikasi kebijakan yang signifikan, terutama dalam pemetaan masalah gizi dan penentuan prioritas intervensi. Penggunaan CIAF memungkinkan identifikasi anak dengan kegagalan gizi multipel yang memiliki risiko kesehatan lebih tinggi. Hal ini membantu pengambil kebijakan dalam:

- a. Menentukan sasaran prioritas program gizi
- b. Mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien
- c. Merancang intervensi yang lebih terintegrasi antara gizi spesifik dan sensitif

Integrasi CIAF dalam sistem pemantauan dan evaluasi program gizi dapat meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan stunting dan masalah gizi lainnya.

3. Pemanfaatan Hasil Penelitian Stunting dalam Perencanaan Program

Hasil penelitian stunting memberikan informasi penting mengenai faktor risiko dan dampak jangka panjang masalah gizi kronis. Penelitian menunjukkan bahwa stunting sering kali berkaitan dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan lintas sektor. Pemanfaatan hasil penelitian stunting dalam perencanaan program gizi mendorong penguatan intervensi pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan, peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan ketahanan pangan rumah tangga.

4. Integrasi Pendekatan Positive Deviance dalam Kebijakan Gizi

Pendekatan Positive Deviance (PD) menekankan pada identifikasi dan penguatan praktik baik yang telah ada di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga dengan praktik PD mampu mempertahankan status gizi anak yang baik meskipun berada dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Integrasi pendekatan PD dalam kebijakan gizi mendorong intervensi yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan dalam program berbasis masyarakat seperti Posyandu dan kegiatan pemberdayaan keluarga, sehingga mendukung perbaikan status gizi secara jangka panjang.

5. Implikasi bagi Implementasi dan Evaluasi Program Gizi

Pemanfaatan hasil penelitian dalam kebijakan gizi tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan, tetapi juga penting dalam implementasi dan evaluasi program. Indikator komprehensif seperti CIAF dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai dampak program gizi secara lebih menyeluruh. Hal ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan dan program yang telah berjalan. Bagi mahasiswa dan calon praktisi kesehatan masyarakat,

pemahaman ini memperkuat kemampuan analisis kebijakan dan evaluasi program berbasis bukti.

6. Tantangan dan Peluang dalam Pemanfaatan Hasil Penelitian

Meskipun hasil penelitian gizi memiliki potensi besar dalam mendukung kebijakan, masih terdapat tantangan dalam pemanfaatannya, seperti keterbatasan kapasitas analisis data, perbedaan kepentingan antar sektor, serta keterbatasan sistem informasi. Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk penguatan kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem data, serta peningkatan komunikasi hasil penelitian menjadi langkah penting dalam menjembatani kesenjangan antara penelitian dan kebijakan.

G. Simpulan

Gizi memiliki peran yang sangat fundamental dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Status gizi yang optimal sejak masa kehamilan hingga usia lanjut berkontribusi terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, sistem imun, serta produktivitas individu. Ketidakseimbangan gizi, baik kekurangan maupun kelebihan, berhubungan erat dengan meningkatnya risiko stunting, anemia, obesitas, penyakit tidak menular, serta penurunan kualitas hidup.

Dalam konteks pembangunan kesehatan masyarakat, gizi tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Hasil berbagai penelitian, termasuk kajian CIAF dan stunting di daerah lokus, menunjukkan bahwa kegagalan pertumbuhan anak berkaitan dengan rendahnya asupan zat gizi, ketahanan pangan keluarga, dan pola asuh yang tidak memadai.

Pemanfaatan pangan lokal menjadi strategi penting dalam perbaikan gizi karena bersifat berkelanjutan, terjangkau, dan sesuai dengan budaya setempat. Bahan pangan lokal seperti ikan, tempe, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayuran, dan buah lokal terbukti mampu memenuhi kebutuhan zat gizi makro dan mikro serta berpotensi sebagai pangan fungsional untuk pencegahan penyakit.

Dengan demikian, intervensi gizi yang berbasis pangan lokal dan didukung oleh edukasi serta kebijakan yang kuat akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan penurunan beban penyakit.

Saran

1. Penguatan intervensi gizi berbasis keluarga dan komunitas perlu menjadi prioritas utama, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting dan kegagalan pertumbuhan (CIAF).

2. Integrasi pangan lokal dalam program kesehatan dan gizi harus ditingkatkan melalui pelatihan pengolahan, pengembangan formula makanan, dan inovasi menu sehat berbasis sumber daya lokal.
3. Perguruan tinggi dan tenaga kesehatan perlu memperkuat pembelajaran berbasis praktik agar mahasiswa gizi memiliki kompetensi dalam menyusun, menilai, dan memodifikasi intervensi pangan sesuai kondisi masyarakat.
4. Kebijakan kesehatan dan ketahanan pangan harus berjalan secara sinergis, sehingga upaya perbaikan gizi tidak terpisah dari upaya peningkatan akses, ketersediaan, dan keamanan pangan.

H. Referensi

- Alemu, Z.A., Geleto, A., Teshome, B. and Endris, B.S. (2023) 'Prevalence and determinants of composite index of anthropometric failure among under-five children', *Food Science & Nutrition*, 11(7), pp. 3650–3662.
- Almatsier, S. (2019) *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Astawan, M. (2018) *Pangan Fungsional untuk Kesehatan*. Bogor: IPB Press.
- Black, R.E., Victora, C.G., Walker, S.P., Bhutta, Z.A., Christian, P., de Onis, M., Ezzati, M., Grantham-McGregor, S., Katz, J., Martorell, R. and Uauy, R. (2013) 'Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries', *The Lancet*, 382(9890), pp. 427–451.
- Bose, K. and Mandal, G.C. (2010) 'Proposed new anthropometric indicator of childhood undernutrition', *Asia Pacific Journal of Public Health*, 22(3), pp. 321–329.
- Chandradewi, A.A.S.P., et.al (2025) *Analisis Positive Deviance dalam Mendukung Ketahanan Pangan terhadap CIAF di Daerah Lokus Stunting*. Mataram: Poltekkes Kemenkes Mataram.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2023) *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. Rome: FAO.
- FAO and WHO (2020) *Food and Nutrition in Health and Disease*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020) *Pedoman Gizi Seimbang*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022) *Pedoman Pelayanan Gizi di Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.

Mahan, L.K. and Raymond, J.L. (2020) *Krause's Food and the Nutrition Care Process*. 15th edn. St. Louis: Elsevier.

UNICEF (2022) *The State of the World's Children 2022: Nutrition*. New York: United Nations Children's Fund.

World Health Organization (2021) *Nutrition and Health*. Geneva: WHO.

WHO (2014) *Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief*. Geneva: World Health Organization.

World Bank (2020) *Human Capital Project: Nutrition Overview*. Washington, DC: World Bank.

I. Glossarium

CIAF = Composite Anthropometric Failure

CHAPTER 6

PENDEKATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN

Syaiful, S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.

A. Pendahuluan / Prolog

Pembangunan kesehatan nasional saat ini menempatkan upaya promotif dan preventif sebagai strategi utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pergeseran paradigma dari pelayanan kesehatan yang berorientasi kuratif menuju pendekatan promotif dan preventif menjadi tuntutan global seiring meningkatnya beban penyakit tidak menular dan masalah kesehatan berbasis perilaku. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, khususnya di layanan kesehatan primer dan komunitas.

Pendekatan promotif dan preventif merupakan fondasi utama dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Bagi mahasiswa keperawatan, pemahaman mendalam tentang strategi promotif (pemberdayaan, edukasi, advokasi) dan preventif (pencegahan primer, sekunder, tersier) sangat penting karena perawat sering menjadi ujung tombak layanan kesehatan di komunitas, puskesmas, dan rumah sakit.

Bab ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan konsep dan kerangka teori promotif dan preventif.
2. Menguraikan peran dan kompetensi perawat dalam intervensi promotif-preventif.
3. Menyajikan strategi pelaksanaan, contoh kegiatan dan alat evaluasi yang dapat diadaptasi oleh tenaga kesehatan maupun mahasiswa keperawatan.

B. Pendekatan Promotif dan Preventif Dalam Tinjauan Teoritis

1. Konsep Dasar Pendekatan Promotif dan Preventif

Pendekatan promotif merupakan upaya yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu, keluarga dan masyarakat dalam mengendalikan determinan kesehatan sehingga mampu mencapai derajat kesehatan optimal. Sementara itu, pendekatan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah munculnya penyakit (pencegahan primer), mendeteksi dini penyakit (pencegahan sekunder) dan mengurangi komplikasi (pencegahan tersier). Kedua

pendekatan tersebut saling melengkapi dan menjadi fondasi utama dalam praktik keperawatan komunitas dan keluarga dengan prinsip pemberdayaan, keterlibatan komunitas, pendekatan lintas sektor, dan berbasis bukti.

Contoh: imunisasi (preventif primer), skrining hipertensi/diabetes (preventif sekunder), rehabilitasi pasca-stroke (preventif tersier).

2. Integrasi Pendekatan Promotif dan Preventif

Integrasi pendekatan promotif dan preventif dalam praktik keperawatan mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Primary Health Care yang menekankan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3. Model dan Teori yang Mendasari Konsep Promotif dan Preventif

Berbagai model dan teori yang mendasari pelaksanaan kegiatan Promotif dan preventif ini memberikan panduan dalam pelaksanaan yang efektif. Beberapa model yang sering digunakan antara lain:

- a. Model Health Belief yang menekankan pentingnya persepsi individu dan komunitas dalam mengambil tindakan kesehatan.
- b. Model Transkultural Leininger yang memperhatikan aspek budaya sebagai faktor penting dalam kegiatan promotif dan preventif.
- c. Model Nursing Process yang sistematis mulai dari pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi intervensi keperawatan. Yang mengandung unsur promotif dan preventif
- d. Teori ecological systems yang menunjukkan interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan sosial-dukungan yang mendukung kegiatan promotif dan preventif.
- e. Teori Transtheoretical Model (stadium perubahan).

Dengan pemahaman konsep-konsep dasar ini, tenaga kesehatan mampu merancang dan melaksanakan pelayanan yang komprehensif yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan komunitas.

4. Peran Perawat dalam Pendekatan Promotif dan Preventif

- a. Kompetensi Inti yang harus dimiliki oleh seorang Perawat
 - 1) Edukator kesehatan: menyusun materi dan melakukan penyuluhan.
 - 2) Pengawas dan pelaksana program: vaksinasi, skrining dan surveilans.
 - 3) Advokat kebijakan kesehatan di komunitas.
 - 4) Koordinator rujukan dan manajemen kasus.
- b. Aktivitas Praktis untuk Mahasiswa Keperawatan
 - 1) Melakukan asesmen kesehatan keluarga dan komunitas (KAP, risiko lingkungan).

- 2) Menyusun rencana intervensi promotif / preventif berbasis bukti (contoh: program berhenti merokok di kampus, promosi gizi seimbang di posyandu).
 - 3) Melakukan health counseling dengan teknik komunikasi yang sesuai (motivational interviewing).
 - 4) Melaksanakan kampanye kesehatan digital (social media) dan pengukuran dampaknya.
- c. Implikasi bagi Pendidikan dan Praktik Keperawatan
- Mahasiswa keperawatan perlu dibekali pemahaman konseptual dan keterampilan praktis terkait pendekatan promotif dan preventif. Kurikulum pendidikan keperawatan harus menekankan pembelajaran berbasis komunitas agar lulusan mampu berkontribusi secara nyata dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5. Strategi Intervensi dan Implementasi

- a. Contoh dan langkah Intervensi Promotif.
- 1) Pendidikan kesehatan terstruktur (materi, metode, evaluasi).
 - 2) Pemberdayaan kader: pelatihan kader posyandu untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang.
 - 3) Lingkungan sehat: advokasi penyediaan air bersih, sanitasi dan fasilitas olahraga.
- Langkah Intervensi Promotif.**
- 1) Analisis kebutuhan (survei singkat/KAP).
 - 2) Perencanaan intervensi (sasaran, indikator, metode).
 - 3) Pelaksanaan (workshop, home visit, kampanye).
 - 4) Evaluasi proses dan hasil.
- b. Contoh dan langkah Intervensi Preventif
- 1) Imunisasi, pemberian profilaksis, skrining penyakit tidak menular (hipertensi, DM), skrining kanker serviks/Payudara.
 - 2) Promosi perilaku sehat: aktivitas fisik, pola makan, pengendalian faktor risiko (merokok, alkohol).
 - 3) Pengukuran keberhasilan:
 - a) Indikator luaran: cakupan imunisasi, persentase populasi yang skrining.
 - b) Indikator hasil: penurunan insiden penyakit, peningkatan kontrol tekanan darah/glukosa.
- c. Integrasi Promotif-Preventif dalam Kuliah Praktikum
- 1) Rencana pembelajaran berbasis kasus (CBL) dan praktik lapangan terstruktur.
 - 2) Penilaian kompetensi: Pelaksanaan OSCE (Objective Structured Clinical Examination) untuk keterampilan konseling dan skrining.

Studi Kasus: Pembelajaran untuk Mahasiswa

Kasus 1: Promosi Kesehatan pada Remaja di Sekolah Menengah

- Situasi:** Tingginya prevalensi perilaku merokok dan konsumsi minuman manis.
- Tugas mahasiswa:** lakukan asesmen KAP, rancang intervensi promotif (kampanye antirokok, penyuluhan gizi), ukur perubahan pengetahuan dan niat.

Kasus 2: Skrining Hipertensi di Puskesmas

- Situasi: Banyak pasien lanjut usia tidak terdiagnosis hipertensi.
- Tugas mahasiswa: siapkan protokol skrining, lakukan skrining, edukasi pencegahan primer, susun rujukan untuk kasus abnormal.

Catatan: Untuk tiap kasus sertakan rencana kegiatan, alat ukur (kuesioner singkat), indikator keberhasilan dan rencana tindak lanjut.

6. Monitoring, Evaluasi dan Indikator Keberhasilan

a. Alat Evaluasi

- 1) Kuesioner pra/post untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan praktek (KAP).
- 2) Indikator layanan (mis. cakupan imunisasi, jumlah skrining, angka rujukan).
- 3) Indikator klinis (mis. rata-rata tekanan darah, kadar gula).

b. Rencana Monitoring

- 1) Pelaporan berkala (mingguan/bulanan) di level puskesmas/komunitas.
- 2) Penggunaan data untuk continuous quality improvement (CQI).

7. Etika, Kultur dan Pertimbangan Kebijakan

a. Etika Praktik Promotif-Preventif

- 1) Memastikan informed consent dalam kegiatan skrining.
- 2) Menghormati kerahasiaan pasien/klien.
- 3) Sensitivitas budaya dalam penyusunan pesan kesehatan.

b. Kebijakan dan Kolaborasi Lintas Sektor

- 1) Peran kebijakan lokal (mis. regulasi rokok, kebijakan gizi sekolah).
- 2) Kolaborasi dengan pendidikan, dinas kesehatan, organisasi masyarakat.

8. Rekomendasi untuk Nakes dan Mahasiswa Keperawatan

- a. Integrasikan pendekatan promotif-preventif dalam setiap interaksi klinis bukan hanya saat praktik komunitas.
- b. Kembangkan keterampilan komunikasi, advokasi, dan evaluasi program.
- c. Manfaatkan teknologi (telehealth, media sosial) untuk menjangkau populasi lebih luas.
- d. Dokumentasikan hasil kegiatan secara sistematis untuk keperluan BKD dan publikasi.

C. Simpulan

Pendekatan promotif dan preventif adalah kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perawat termasuk mahasiswa keperawatan memiliki peran sentral sebagai edukator, pelaksana program, dan advokat. Dengan penerapan strategi berbasis bukti, evaluasi yang sistematis, dan kolaborasi lintas sektor, intervensi promotif-preventif dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan populasi.

Pendekatan promotif dan preventif merupakan strategi esensial dalam peningkatan derajat kesehatan. Perawat memiliki peran kunci dalam implementasi kedua pendekatan ini melalui praktik keperawatan yang holistik, komprehensif, dan berorientasi pada masyarakat.

D. Referensi

- World Health Organization. (2010). Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. WHO.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Transformasi Sistem Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.
- World Health Organization. Ottawa Charter for Health Promotion. WHO; 1986.
- Green LW, Kreuter MW. Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach. 4th ed. McGraw-Hill; 2005.
- Pender NJ, Murdaugh CL, Parsons MA. Health Promotion in Nursing Practice. 7th ed. Pearson; 2015.
- World Health Organization. Health Promotion Glossary. WHO; 1998.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rencana Aksi Nasional Promosi Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI; 2017.
- Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing. 9th ed. Elsevier; 2017.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Principles of Community Engagement. 2nd ed. CDC/ATSDR; 2011.
- Nutbeam D. Health promotion glossary. Health Promotion International. 1998;13(4):349–64.
- Baum F. The New Public Health. 4th ed. Oxford University Press; 2015.

Mahmudiono T, et al. (contoh jurnal lokal terkait promosi/pencegahan) — mohon lampirkan jika ingin saya sertakan sitasi lokal spesifik.

E. Glosarium

Derajat Kesehatan: Ukuran tingkat kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seseorang atau masyarakat yang biasanya diukur melalui indikator angka harapan hidup, angka kematian, dan status gizi.

Deteksi Dini: Usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kondisi kesehatan pada tahap awal sebelum gejala klinis muncul secara nyata (skrining).

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP): Tempat pertama yang didatangi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, atau praktik dokter mandiri.

Imunisasi: Proses pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu.

Intervensi: Tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi kesehatan atau perilaku masyarakat menuju arah yang lebih baik.

Kuratif: Upaya kesehatan yang fokus pada penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan, dan pengendalian dampak penyakit.

Pemberdayaan Masyarakat: Proses pemberian kemampuan atau kemandirian kepada masyarakat agar mereka dapat mengenali dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri.

Pencegahan Primer (Primary Prevention): Upaya yang dilakukan sebelum seseorang terkena penyakit, bertujuan menghilangkan faktor risiko (misalnya: vaksinasi, sanitasi).

Pencegahan Sekunder (Secondary Prevention): Upaya menghentikan perkembangan penyakit ke tahap yang lebih parah melalui diagnosis dini dan pengobatan segera.

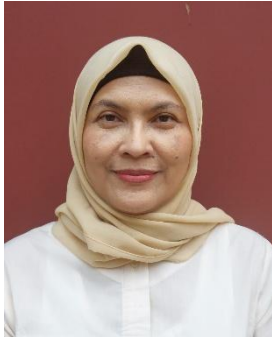
Pencegahan Tersier (Tertiary Prevention): Upaya yang difokuskan pada rehabilitasi dan pengurangan kecacatan akibat penyakit kronis.

PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat): Sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan.

Promosi Kesehatan: Proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kendali atas kesehatan mereka dan meningkatkan status kesehatan mereka melalui edukasi dan perubahan lingkungan.

Rehabilitatif: Upaya pemulihan kesehatan penderita agar dapat berfungsi kembali secara normal di tengah masyarakat.

PROFIL PENULIS



Aisyah Maulina Zjubaidi, SKM, M.Si. Lahir di Kudus, 10 Mei 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia tahun 1995. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia mengambil Program Studi Magister Terapan Psikologi Kesehatan dan lulus tahun 2008. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 di Pusat Penelitian Keluarga Sejahtera Universitas Indonesia, kemudian menjadi fasilitator pada *workshop Problem Solving for Better Health/Hospital* yang banyak bekerja dengan sumber daya manusia kesehatan di Indonesia. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamentas mengampu mata kuliah Psikologi, Antropologi Kesehatan dan Pengembangan Kepribadian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai peneliti, penulis buku, pembicara webinar dan pelatihan tenaga kesehatan. Penulis aktif sebagai anggota Kelompok Kerja Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aisyahmz@gmail.com



Riwayat pendidikan:

- Penulis menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
- Melanjutkan pendidikan Sarjana Terapan Kebidanan di STIKes Mitra Ria Husada Jakarta
- Menanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di STIKIM Jakarta
- Menanjutkan pendidikan Profesi Bidan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
- Dan Kemudian melanjutkan pendidikan S3 Manajemen pendidikan di

UNINUS Bandung

Sejak tahun 2015 penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen Ilmu Kebidanan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia sampai saat ini. Penulis juga aktif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Penulis dapat dihubungi melalui email: kurshisulatri7@gmail.com atau pada kontak 081382388476.

Pesan untuk para pembaca:

"Membaca adalah nafas hidup dan jembatan emas untuk masa depan, semakin banyak membaca makin banyak memperoleh informasi."



PROFIL PENULIS



Ayu Mustika Handayani, S.ST., M.Kes

Lahir di Petran Jaya, tanggal 15 Mei 1992. Telah menyelesaikan studi pada DIII Kebidanan STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu Tahun 2012, lulus DIV Kebidanan STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu tahun 2013, lulus S2 Kesehatan Masyarakat di STIK Bina Husada Palembang Tahun 2016. Saat ini sebagai dosen tetap Program Studi D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Nusantara Indonesia Lubuk Linggau. Sebagai tim penulis pada 'Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui' yang telah disusun bersama tim. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ayu.muha15@gmail.com



Resta Betaliani Wirata, S.Kep., Ns., MSN Lahir di Purbalingga, 21 Oktober 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada St. Paul University Manila dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 sebagai dosen keperawatan maternitas di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan poster presentasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: resta@stikesbethesda.ac.id

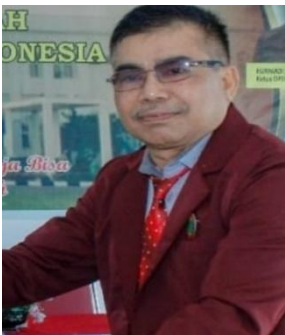


PROFIL PENULIS



AASP Chandradewi SKM.M.Kes Lahir di Denpasar Bali 02 Agustus 1962. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tahun 1996 Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjahmada dan lulus tahun pada tahun 2002. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1986 sampai tahun 1991 di RSUP Sanglah Denpasar dan Mengajar di akademi Gizi Denpasar Pada tahun 1991 – 1992 bekerja di Kanwil Kesehatan Nusa Tenggara Barat Tahun 1992 sampai saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Mataram dan mengampu mata kuliah Ilmu gizi, Gizi Kuliner, Gizi dalam daur kehidupan, Pengembangan Formula Pangan, Manajemen Usaha Jasa Boga, Manajemen Makanan Institusi, Gizi dan Kebugaran, Pengembangan Gizi Kuliner Makanan Rumah Sakit, Manajemen Mutu Makanan Institusi ,Manajemen konseling ASI dan MP- ASI ini Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Juri dan Narasumber dalam bidang Gizi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: chandradewi568@yahoo.com

Motto: "Stay positive, work hard, make it happen."



Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., MPd., MKes. Lahir di kota Bima-NTB, , 23 Mei 1968, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Adibuna Surabaya dengan gelar M.Pd pada tahun 2009 sedangkan gelar M.Kes diraih pada universitas Badaruddin Lombok Tengah NTB lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 Prodi Keperawatan Bima Akper Depkes Mataram NTB sampai saat ini sudah dikonversi menjadi Poltekkes Kememkes Mataram. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Mataram-NTB mengampu mata kuliah Metodologi penelitian, Konsep Dasar Keperawatan, Manajemen Keperawatan, Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Keluarga/Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi Ilmiah, nara sumber berbagai seminar dan Workshop, dll, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: syaiful6823mpd@gmail.com

Motto: "Sehatkan Hari Ini, Hebatkan Masa Depan, Karena Mencegah Adalah Bukti Cinta pada Diri." Ipoel G'Ade 2026.

Sinopsis

"Bunga Rampai: Peran Strategis Tenaga Kesehatan dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat" merupakan buku yang menghimpun berbagai gagasan, kajian, dan praktik aplikatif mengenai kontribusi tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Buku ini menegaskan bahwa derajat kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh layanan kuratif, tetapi dibentuk oleh interaksi berbagai determinan lingkungan, perilaku, ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta faktor genetic yang memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif.

Melalui bunga rampai ini, pembaca diajak memahami konteks kesehatan masyarakat Indonesia yang dinamis: keberhasilan penurunan beberapa indikator kesehatan di satu sisi, namun masih tingginya beban penyakit menular, penyakit tidak menular, dan ketimpangan akses layanan di sisi lain. Dalam situasi tersebut, tenaga kesehatan diposisikan sebagai aktor kunci yang menjalankan peran promotif, preventif, edukatif, advokatif, serta koordinator layanan berbasis komunitas. Buku ini juga menyoroti pentingnya penguatan pelayanan primer, peningkatan literasi kesehatan, deteksi dini dan skrining, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat sebagai strategi untuk menekan faktor risiko dan memperbaiki kualitas hidup.

Selain aspek konseptual, buku ini menghadirkan pendekatan praktis dan kontekstual untuk implementasi program kesehatan: kolaborasi interprofesional, kemitraan lintas sektor, inovasi pemanfaatan teknologi digital, dan strategi intervensi yang sensitif budaya. Dengan demikian, buku ini tidak hanya bermanfaat sebagai referensi akademik, tetapi juga sebagai panduan reflektif bagi mahasiswa kesehatan, praktisi, pendidik, pengelola program, serta pemangku kebijakan dalam merancang dan menjalankan upaya peningkatan kesehatan yang efektif, adil, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, "Bunga Rampai: Peran Strategis Tenaga Kesehatan dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat" diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat peran tenaga kesehatan sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan kesehatan, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.

“Bunga Rampai: Peran Strategis Tenaga Kesehatan dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat” merupakan buku yang menghimpun berbagai gagasan, kajian, dan praktik aplikatif mengenai kontribusi tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Buku ini menegaskan bahwa derajat kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh layanan kuratif, tetapi dibentuk oleh interaksi berbagai determinan lingkungan, perilaku, ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta faktor genetic yang memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif.

Melalui bunga rampai ini, pembaca diajak memahami konteks kesehatan masyarakat Indonesia yang dinamis: keberhasilan penurunan beberapa indikator kesehatan di satu sisi, namun masih tingginya beban penyakit menular, penyakit tidak menular, dan ketimpangan akses layanan di sisi lain. Dalam situasi tersebut, tenaga kesehatan diposisikan sebagai aktor kunci yang menjalankan peran promotif, preventif, edukatif, advokatif, serta koordinator layanan berbasis komunitas. Buku ini juga menyoroti pentingnya penguatan pelayanan primer, peningkatan literasi kesehatan, deteksi dini dan skrining, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat sebagai strategi untuk menekan faktor risiko dan memperbaiki kualitas hidup.

Selain aspek konseptual, buku ini menghadirkan pendekatan praktis dan kontekstual untuk implementasi program kesehatan: kolaborasi interprofesional, kemitraan lintas sektor, inovasi pemanfaatan teknologi digital, dan strategi intervensi yang sensitif budaya. Dengan demikian, buku ini tidak hanya bermanfaat sebagai referensi akademik, tetapi juga sebagai panduan reflektif bagi mahasiswa kesehatan, praktisi, pendidik, pengelola program, serta pemangku kebijakan dalam merancang dan menjalankan upaya peningkatan kesehatan yang efektif, adil, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, “Bunga Rampai: Peran Strategis Tenaga Kesehatan dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat” diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat peran tenaga kesehatan sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan kesehatan, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7556-79-0 (PDF)



9

786347

556790

